



Cas Clinique IST Partie 2



Dr. Makram Koubaa

05/07/2025

➔ Cas clinique : Suite...

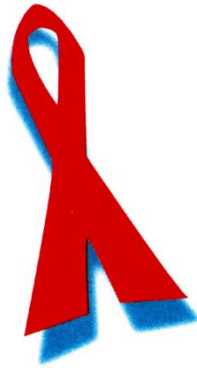
- 2 ans plus tard ...
- Eruption Maculo-papuleuse
- Prédomine sur le tronc
- Biologie:
 - thrombopénie
 - ASAT et ALAT ↑





Quel est votre diagnostic ?

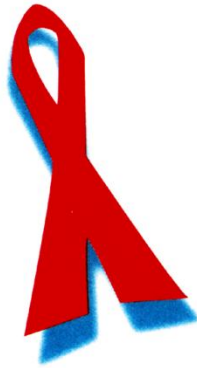
- A. Roséole syphilitique
- B. Rougeole
- C. Primo-infection VIH
- D. Rubéole
- E. MNI





Quel est votre diagnostic ?

- A. Roséole syphilitique
- B. Rougeole
- C. Primo-infection VIH
- D. Rubéole
- E. MNI



Réponse: C





QCM

Parmi les signes suivants, quels sont ceux que vous ne retrouvez pas lors de la primo-infection VIH:

- A. La leucoplasie chevelue de la langue**
- B. Le sarcome de Kaposi**
- C. La diarrhée chronique**
- D. Les ulcérations génitales**
- E. La méningite lymphocytaire**



QCM

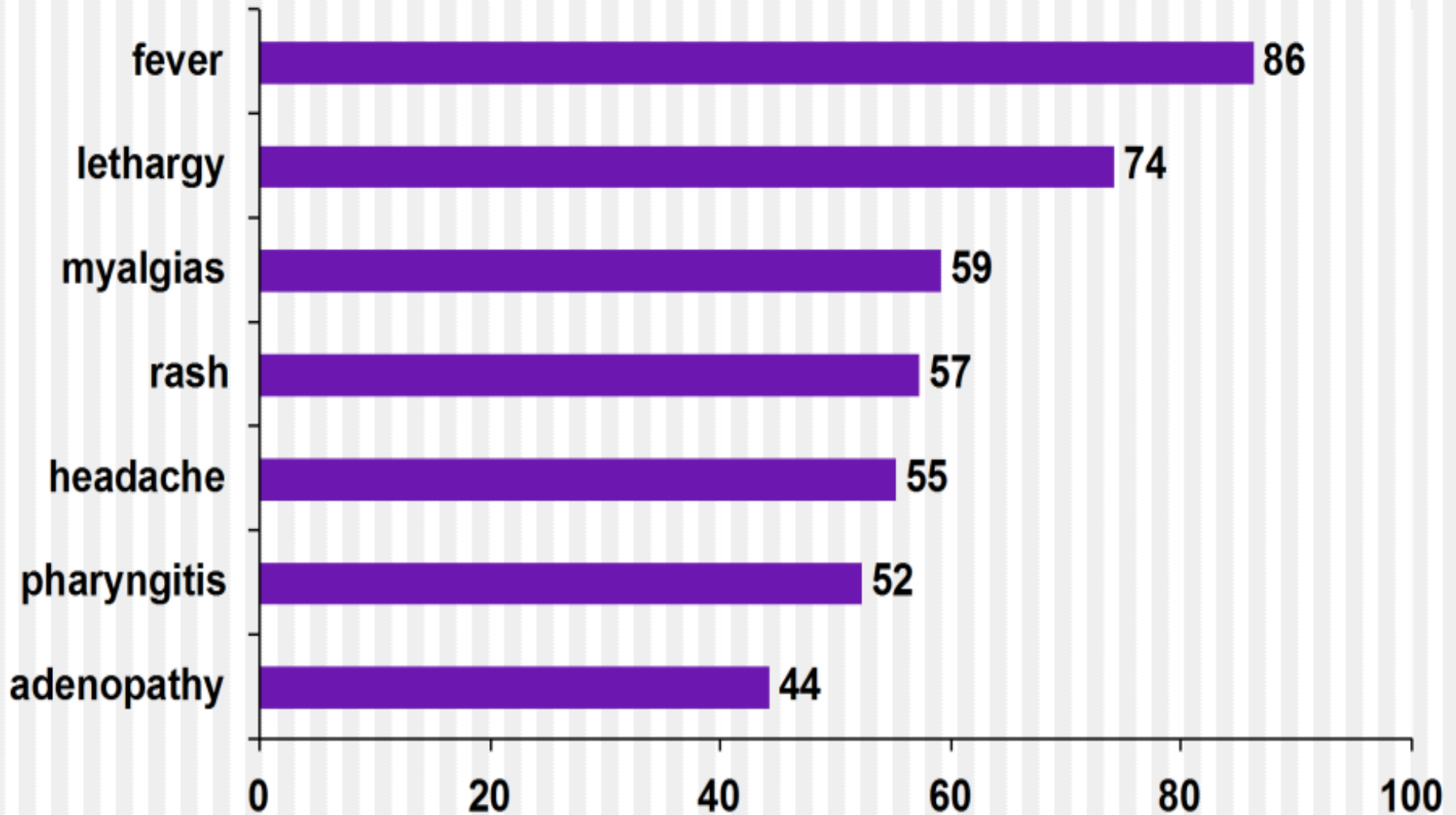
Parmi les signes suivants, quels sont ceux que vous ne retrouvez pas lors de la primo-infection VIH:

- A. La leucoplasie chevelue de la langue**
- B. Le sarcome de Kaposi**
- C. La diarrhée chronique**
- D. Les ulcérations génitales**
- E. La méningite lymphocytaire**

A – B – C

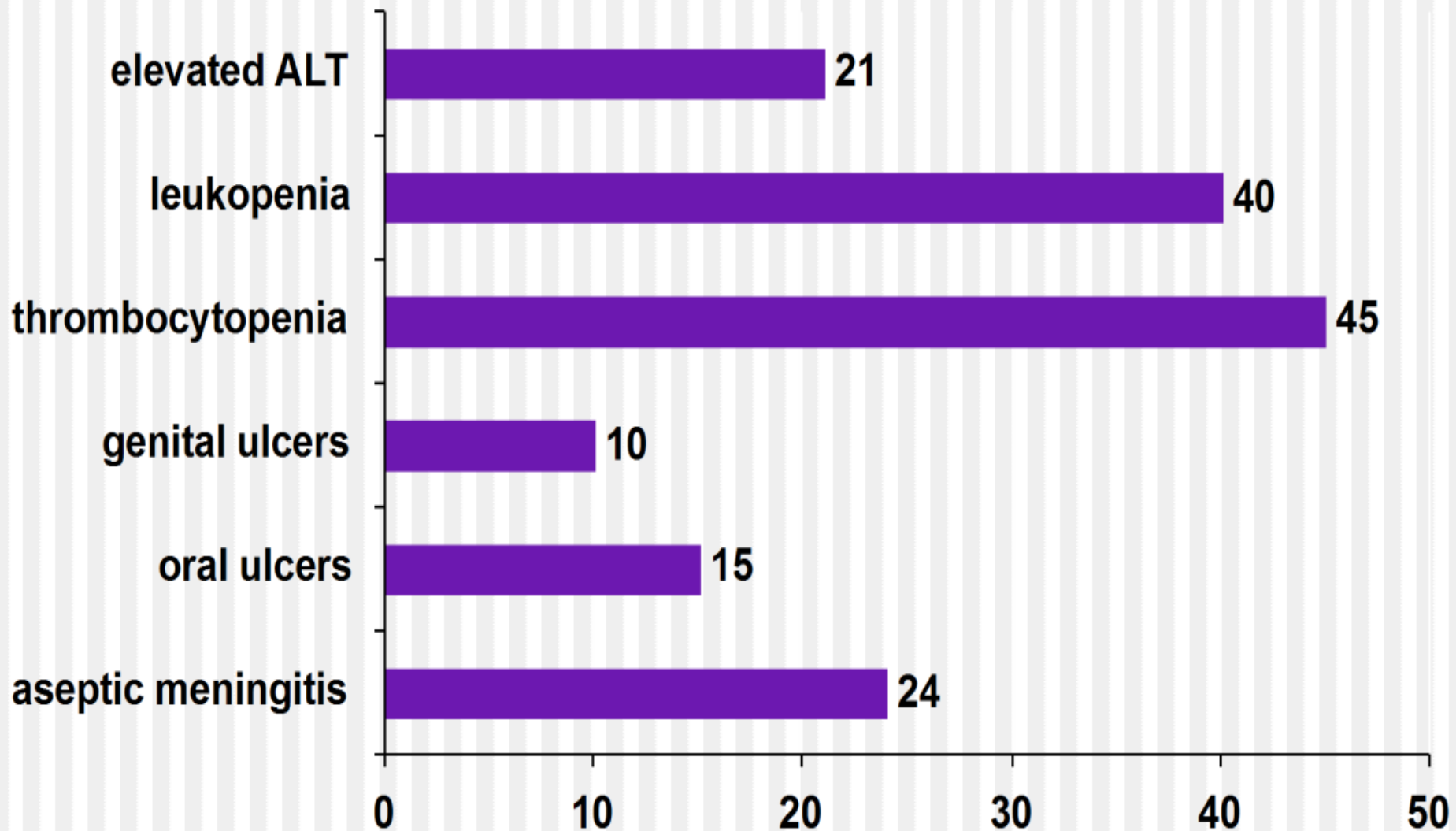


Primo-infection VIH : Clinique





Primo-infection VIH : Autres



➔ Quelques caractéristiques du VIH

1. Peu résistant dans l'environnement extérieur
2. Survit à l'extérieur : qq min-qq H
3. Il est inactivé rapidement par:
 - a. Chaleur (56°C pendant 10 minutes)
 - b. Peroxyde d'hydrogène, alcool éthylique 40%
 - c. Hypochlorite de sodium à la concentration de 10%
 - d. Para formaldéhyde, rayons ultraviolets



QCM

Le virus de l'immunodéficience humaine :

- A. est lymphotrope.**
- B. est neurotrope**
- C. a une activité transcriptase inverse**
- D. a un noyau central d'ADN**
- E. est un adénovirus**



QCM

Le virus de l'immunodéficience humaine :

- A. est lymphotrope.**
- B. est neurotrope**
- C. a une activité transcriptase inverse**
- D. a un noyau central d'ADN**
- E. est un adénovirus**

A – B – C



QROC

Citer 3 cellules cibles du VIH :



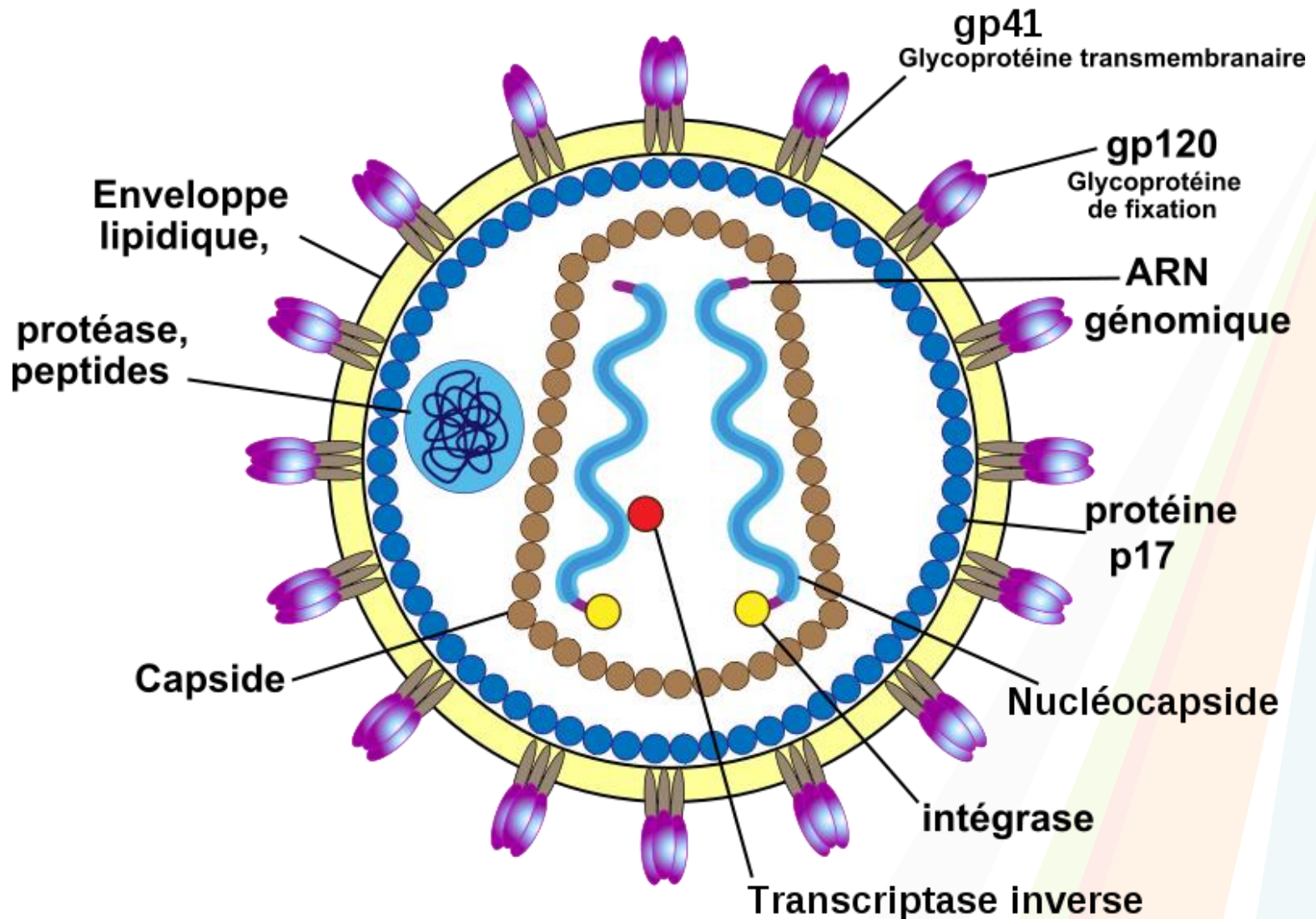
QROC

Citer 3 cellules cibles du VIH :

- **LT CD4+**
- **Macrophages, monocytes**
- **Cellules de Langerhans de la peau**
- **Cellules microgliales cérébrales**

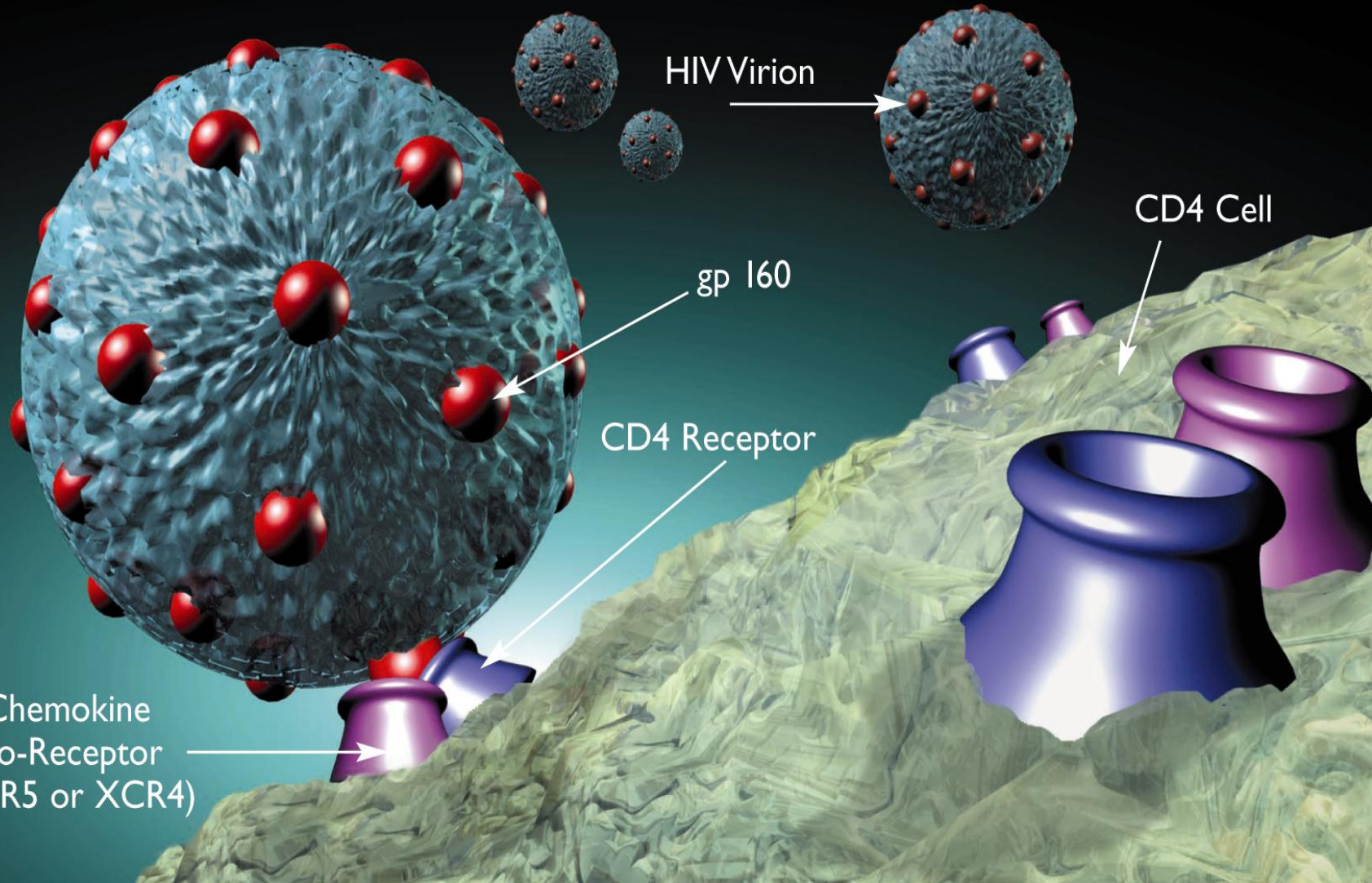


VIH : Virologie





VIH : Virologie



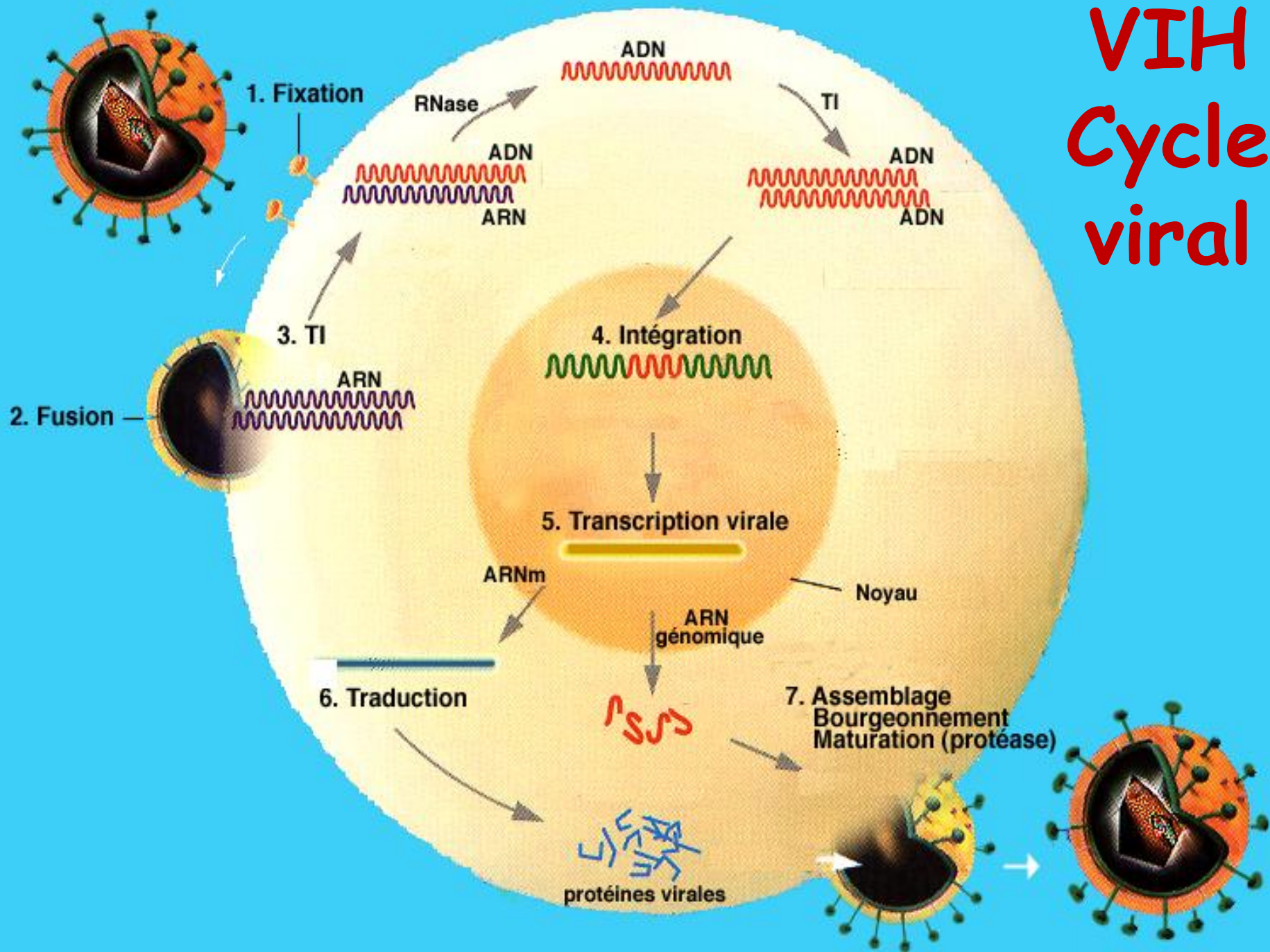


VIH : *Cycle viral*



Cycle.exe

VIH Cycle viral





QCM

Les cellules cibles du VIH sont :

- A. Les lymphocytes T CD4+**
- B. Les monocytes/macrophages**
- C. Les cellules microgliales du cerveau**
- D. Les cellules dendritiques du cerveau**
- E. Les cellules folliculaires des ganglions**



QCM

Les cellules cibles du VIH sont :

- A. Les lymphocytes T CD4+**
- B. Les monocytes/macrophages**
- C. Les cellules microgliales du cerveau**
- D. Les cellules dendritiques du cerveau**
- E. Les cellules folliculaires des ganglions**

A – B – C – E



**Citer les 3 principaux modes de contamination
par le VIH :**



Citer les 3 principaux modes de contamination par le VIH :

- **Sang et dérivés**
- **Sexe**
- **Mère-enfant**



Comment se transmet le VIH ?

- A. Rapports sexuels**
- B. Materno-fœtale**
- C. Baiser**
- D. Piqure d'insecte**
- E. Transfusion**



Comment se transmet le VIH ?

- A. Rapports sexuels
- B. Materno-fœtale
- C. Baiser
- D. Piqure d'insecte
- E. Transfusion

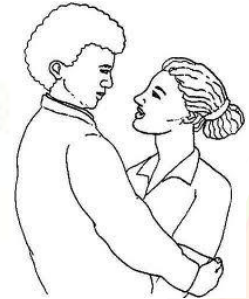
Réponse : A-B-E



VIH : Transmission ?

SEXE +++

Hétérosexuel (rapports
génitaux, orogénitaux)
Homosexuel (rapports
anaux, orogénitaux)



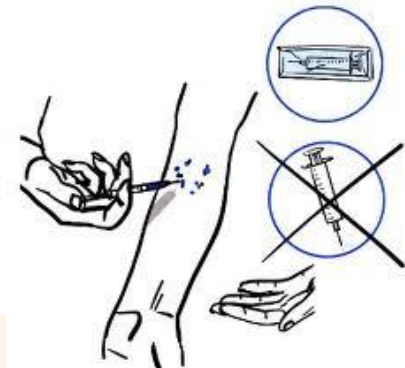
SANG

Toxicomanie
Transfusion
Greffe d'organe
Hémophilie
AES

MATERNO-FOETAL
+ Allaitement



Pas de risque :
baiser, piqure d'insecte, vaisselle





QCM

Les facteurs de risque de la transmission sexuelle du VIH sont:

- A. Une charge virale plasmatique élevée du partenaire**
- B. La phase de primo-infection**
- C. Des CD4 supérieurs à $200/\text{mm}^3$**
- D. La présence d'ulcères génitaux**
- E. Le saignement au cours du rapport sexuel**



QCM

Les facteurs de risque de la transmission sexuelle du VIH sont:

- A. Une charge virale plasmatique élevée du partenaire**
- B. La phase de primo-infection**
- C. Des CD4 supérieurs à 200/mm³**
- D. La présence d'ulcères génitaux**
- E. Le saignement au cours du rapport sexuel**

A – B – D – E



Citer 4 facteurs augmentant les risques de transmission sexuelle du VIH :



Citer 4 facteurs augmentant les risques de transmission sexuelle du VIH :

- **Partenaire avec charge virale élevée**
- **SIDA déclaré**
- **Présences de lésions génitales**
- **Primo-infection**
- **Présence d'autres IST**
- **Rapport anal**
- **Rapport réceptif**
- **Nombre élevé des partenaires**



QCM

Concernant la transmission du VIH de la mère à l'enfant :

- A. Elle ne survient qu'au moment de l'accouchement**
- B. L'allaitement maternel n'a pas de risque**
- C. La charge virale plasmatique maternelle constitue un facteur de risque**
- D. La prise des antiviraux par la mère permet de réduire le risque**
- E. La prise des antiviraux par l'enfant permet de réduire le risque**



QCM

Concernant la transmission du VIH de la mère à l'enfant :

- A. Elle ne survient qu'au moment de l'accouchement**
- B. L'allaitement maternel n'a pas de risque**
- C. La charge virale plasmatique maternelle constitue un facteur de risque**
- D. La prise des antiviraux par la mère permet de réduire le risque**
- E. La prise des antiviraux par l'enfant permet de réduire le risque**

C – D – E

**Quel est le nombre de cas de sujets
Infectés par le VIH en Tunisie en 2023**

A. 1357

B. 2357

C. 3357

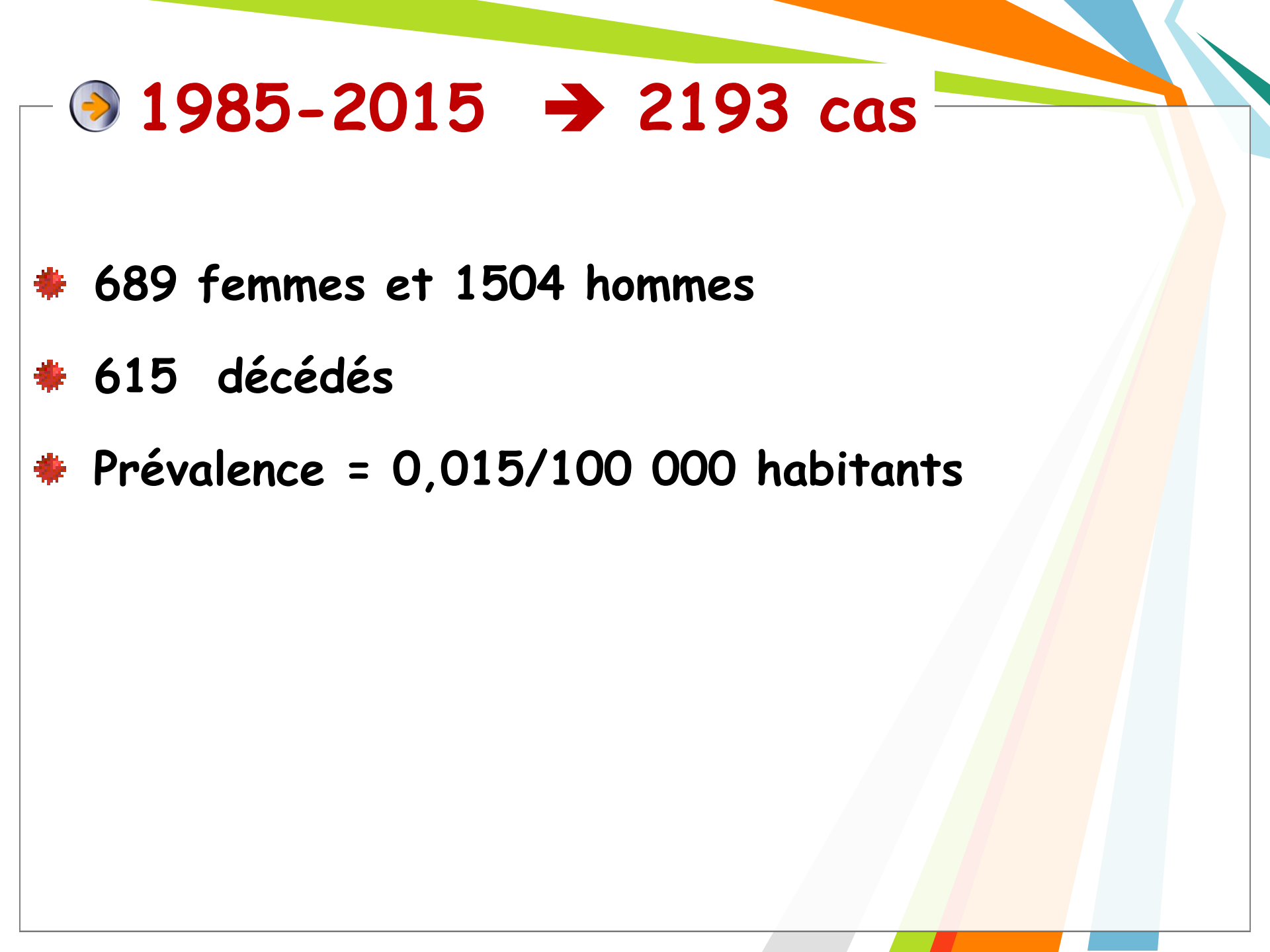
D. 6000

E. 8000

**Quel est le nombre de cas de sujets
Infectés par le VIH en Tunisie en 2023**

- A. 1357**
- B. 2357**
- C. 3357**
- D. 6000**
- E. 8000**

Réponse : E

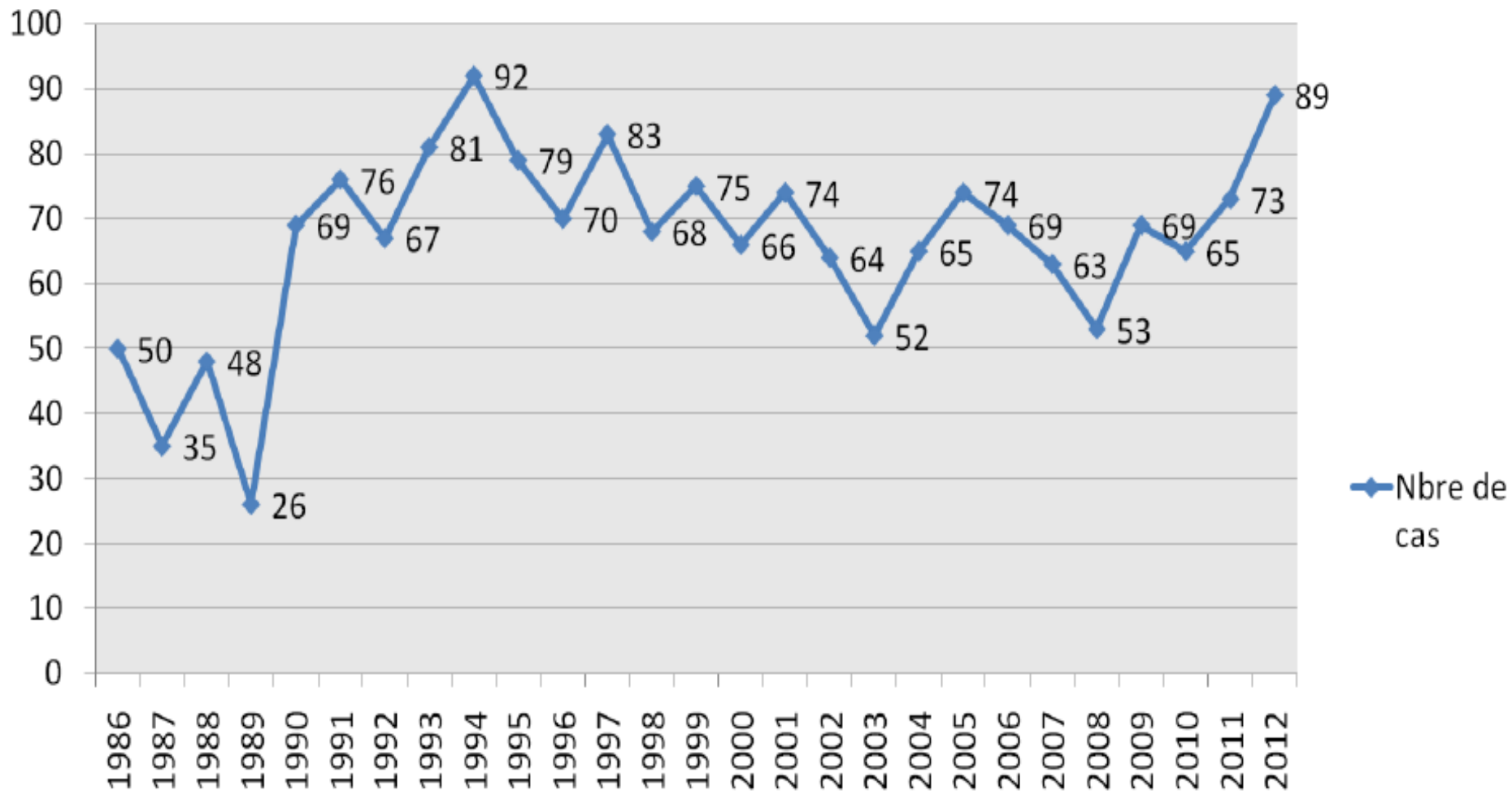


➡ **1985-2015 → 2193 cas**

- ✱ **689 femmes et 1504 hommes**
- ✱ **615 décédés**
- ✱ **Prévalence = 0,015/100 000 habitants**

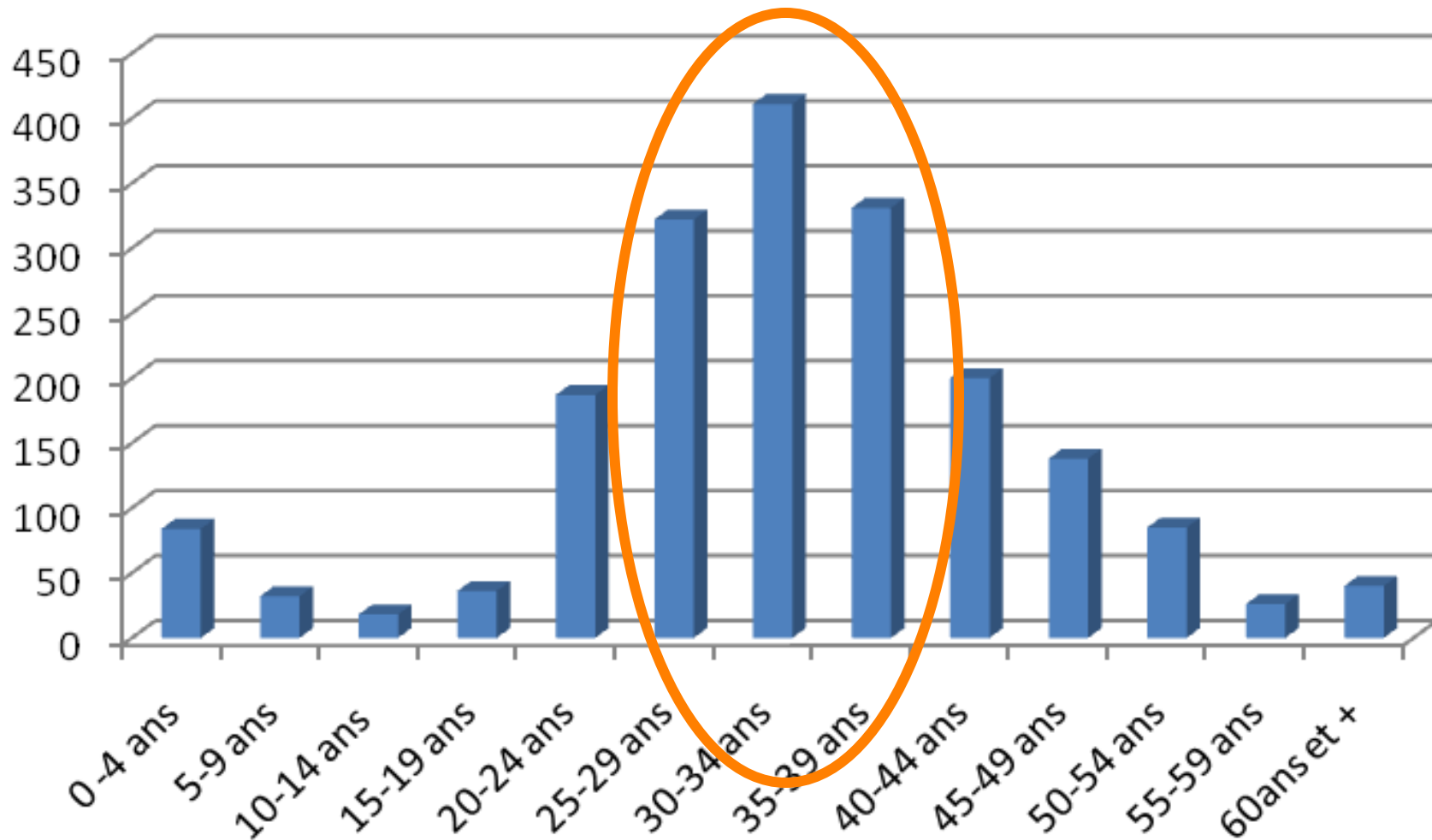


Nouveaux cas détectés 1985-2012





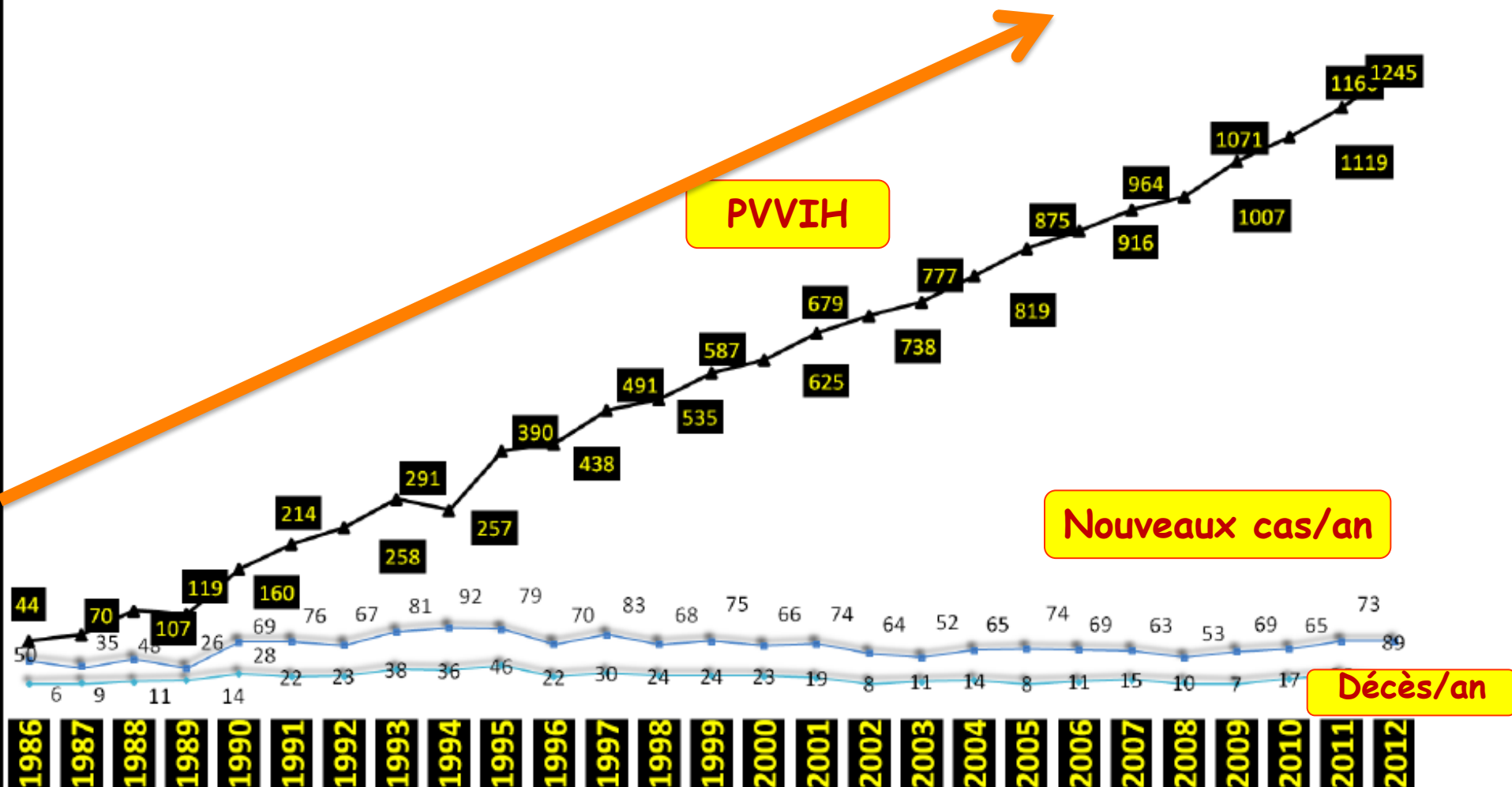
Répartition par sexe & âge 2015





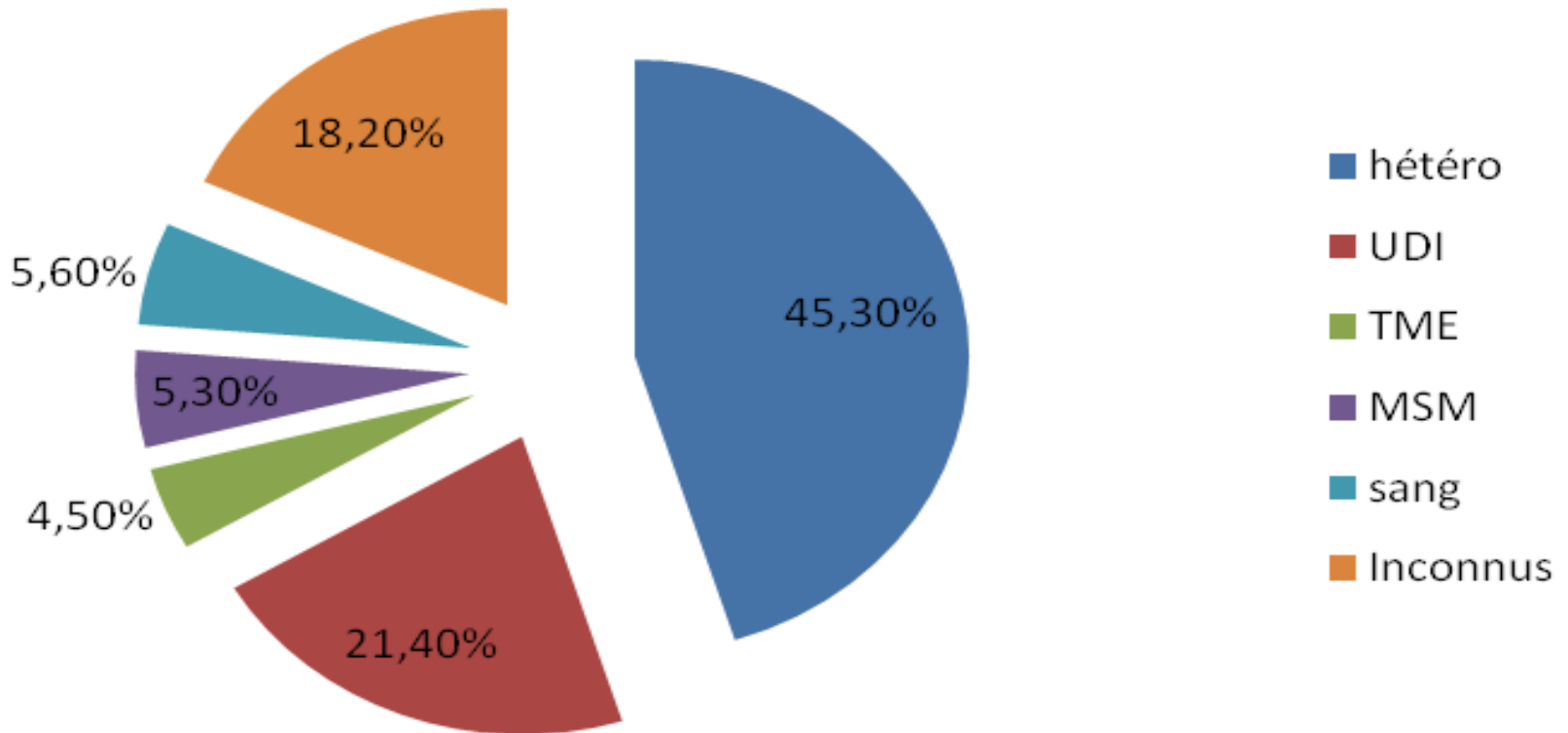
Progression du VIH en Tunisie

1245 PVVIH + 550 décès





Modes de transmission chez les 2 sexes (2193 cas) 1985 - 2015





Comment faire de dg de l'infection par le VIH chez notre patient ?

- A. ARN VIH**
- B. Sérologie VIH**
- C. Test rapide VIH**
- D. Western Blot VIH**
- E. Ag P24**



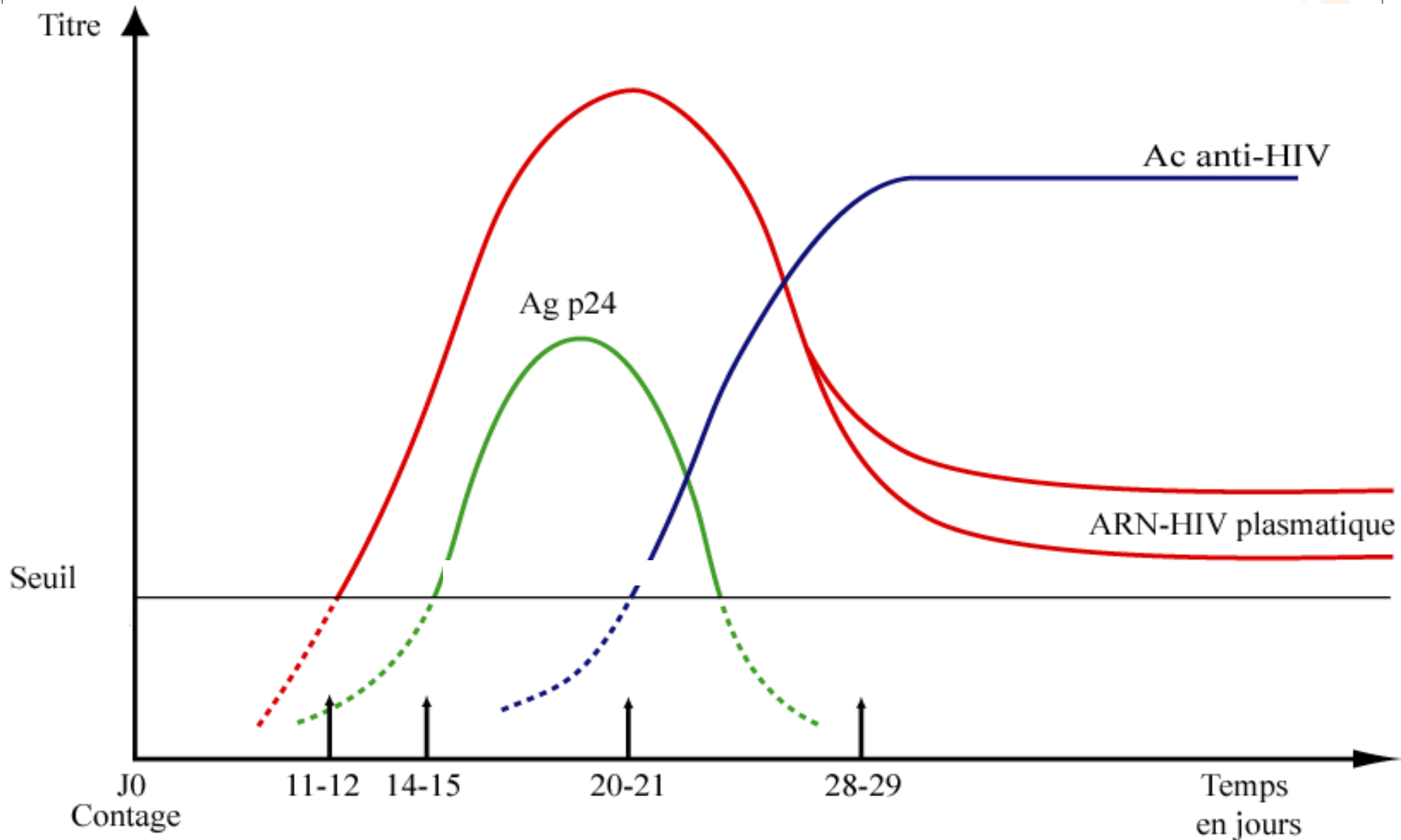
Comment faire de dg de l'infection par le VIH chez notre patient ?

- A. ARN VIH**
- B. Sérologie VIH**
- C. Test rapide VIH**
- D. Western Blot VIH**
- E. Ag P24**

Réponse : A



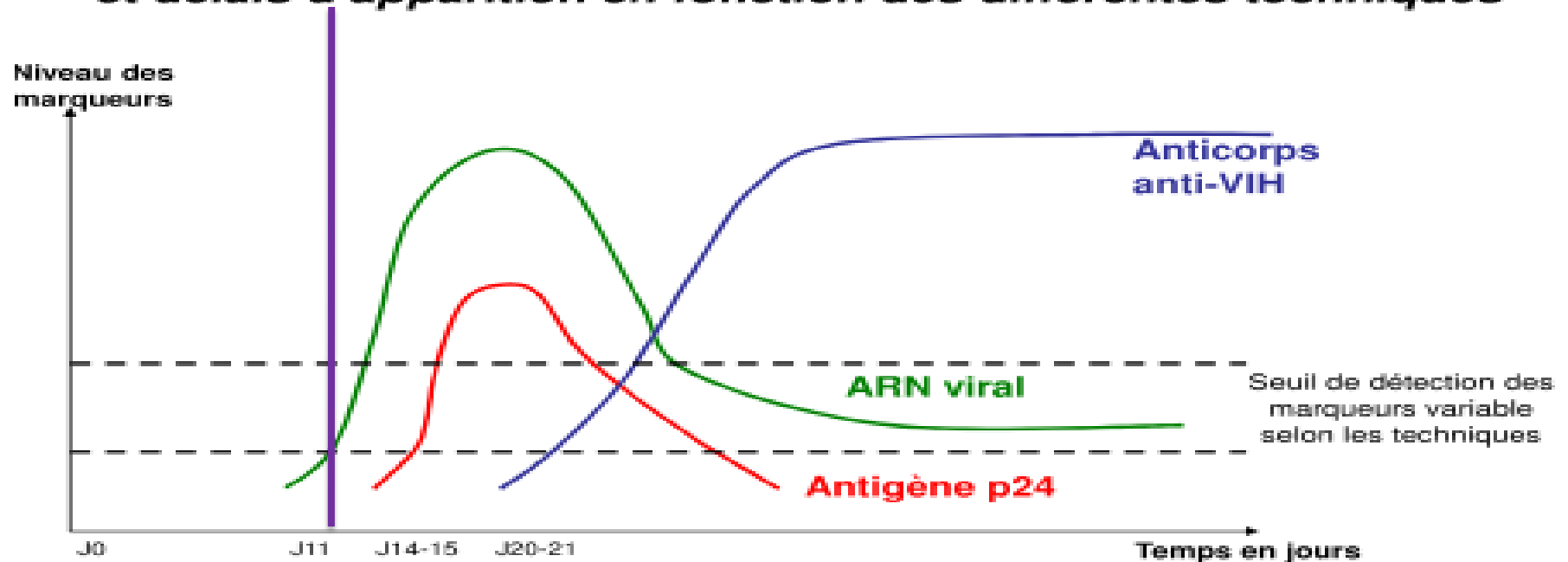
VIH : Evolution des marqueurs virologiques





Dépistage : Histoire naturelle

*Evolution des marqueurs biologiques
et délais d'apparition en fonction des différentes techniques*



À partir de J10-J12 : détection de l'ARN par PCR

À partir de J14-J15 : détection de l'Ag p24 par Elisa combiné 4G

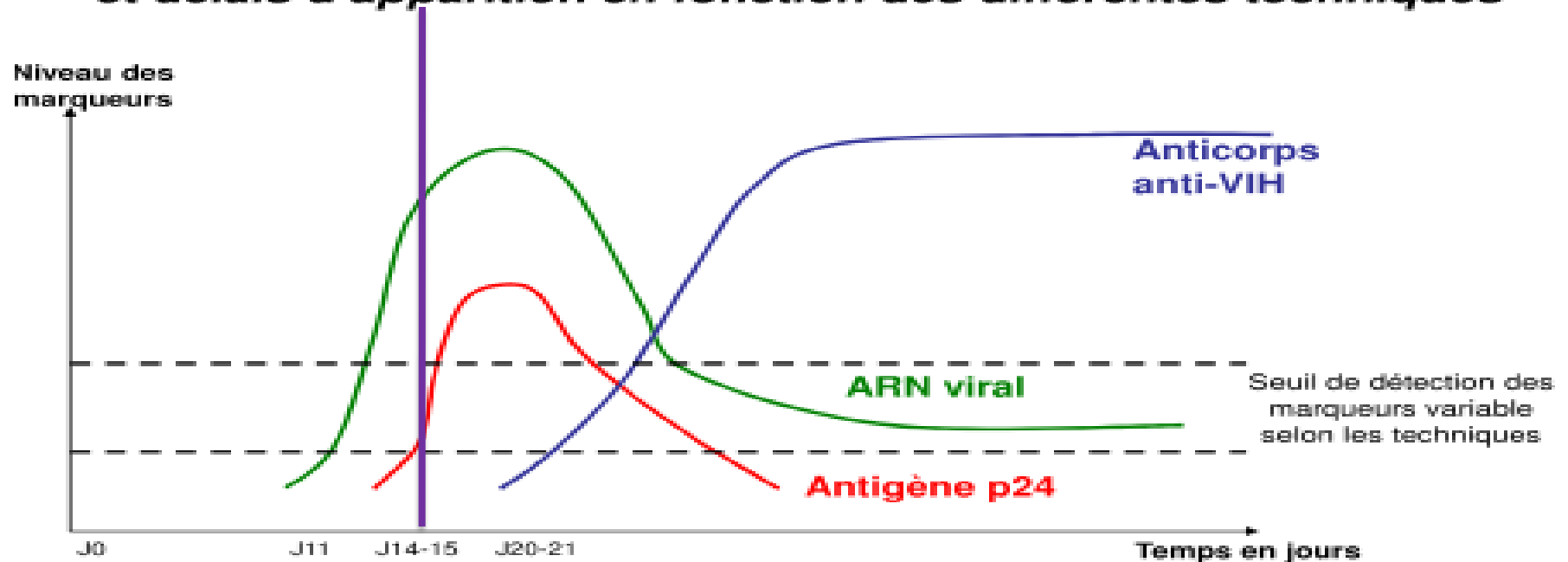
À partir de J20-J21 : détection des Ac anti-VIH par Elisa

À partir de J26 : détection des Ac anti-VIH
par Western-Blot et parTROD



Dépistage : Histoire naturelle

*Evolution des marqueurs biologiques
et délais d'apparition en fonction des différentes techniques*



À partir de J10-J12 : détection de l'ARN par PCR

À partir de J14-J15 : détection de l'Ag p24 par Elisa combiné 4G

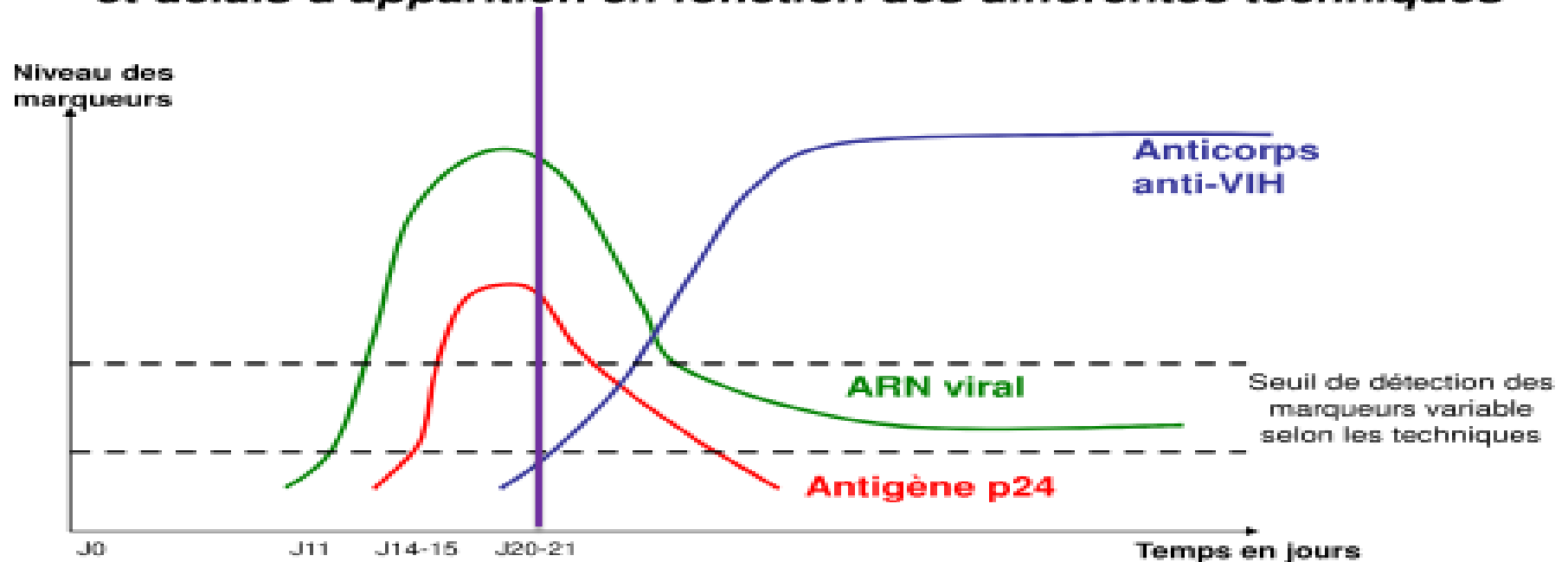
À partir de J20-J21 : détection des Ac anti-VIH par Elisa

À partir de J26 : détection des Ac anti-VIH
par Western-Blot et parTROD



Dépistage : Histoire naturelle

*Evolution des marqueurs biologiques
et délais d'apparition en fonction des différentes techniques*



À partir de J10-J12 : détection de l'ARN par PCR

À partir de J14-J15 : détection de l'Ag p24 par Elisa combiné 4G

À partir de J20-J21 : détection des Ac anti-VIH par Elisa

À partir de J26 : détection des Ac anti-VIH
par Western-Blot et parTROD



QROC

Citer 2 tests sérologiques permettant la confirmation d'une infection VIH :



QROC

Citer 2 tests sérologiques permettant la confirmation d'une infection VIH :

- **ELISA**
- **WESTERN BLOT**



QROC

Dans quel cas le dépistage du VIH est obligatoire et légal ?



QROC

Dans quel cas le dépistage du VIH est obligatoire et légal ?

- **Don de sang ou d'organes**

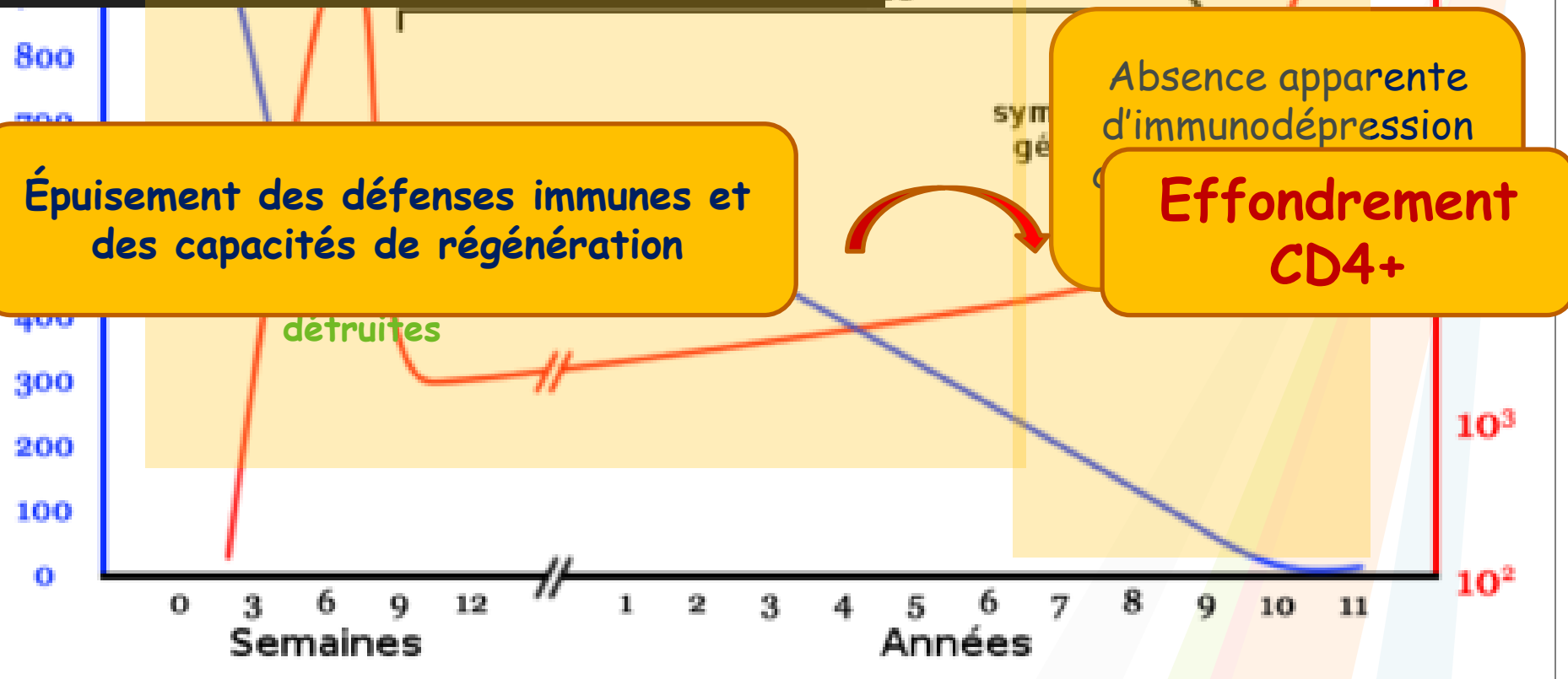
Malgré la **Réplication virale continue**
 persiste la **Destruction continue des CD4**
 ▪ **Se crée** Émergence continue de variants viraux
 infectée Apparition de souches virales virulentes
 ▪ Constitutive

es lymphoïdes)

la réponse

VIH: **organes lymphoïdes**

▪ Efficacité limitée des AC anti-VIH



VIH : Histoire naturelle



Progression de la Maladie:

Charge Virale et Numération de CD4





Classification du VIH CDC 1993

Nombre de lymphocytes CD4/mm ³	Catégories cliniques		
	A Asymptomatique Primo-infection ADP chroniques	B Symptomatique sans critères C	C Tumeurs Infections opportunistes
≥ 500	A1	B1	C1
200 - 499	A2	B2	C2
< 200	A3	B3	C3

CATÉGORIE A

- Infection VIH asymptomatique
- Lymphadénopathie persistante généralisée
- Primo-infection symptomatique

CATÉGORIE B

- Angiomatose bacillaire
- Candidose oropharyngée
- Candidose vaginale, persistante, fréquente ou qui répond mal au traitement
- Dysplasie du col (modérée ou grave), carcinome in situ
- Syndrome constitutionnel : fièvre (38°5C) ou diarrhée > à 1 mois
- Leucoplasie chevelue de la langue
- Zona récurrent ou envahissant plus d'un dermatome
- Purpura thrombocytopénique idiopathique
- Listériose
- Neuropathie périphérique

CATÉGORIE C

- Candidose bronchique, trachéale ou extra pulmonaire
- Candidose oesophagienne
- Cancer invasif du col
- Coccidioidomycose
- Cryptococcose extra pulmonaire
- Cryptosporidiose intestinale > 1 mois
- Infection à CMV (autre que foie, rate, ganglions)
- Rétinite à CMV
- Encéphalopathie due au VIH
- Infection herpétique, ulcères chroniques > 1 mois ou bronchique, pulmonaire ou œsophagienne
- Histoplasmosse disséminée ou extra pulmonaire
- Isosporidiose intestinale chronique (>1 mois)
- Sarcome de kaposi
- Lymphome cérébral primaire
- Infection à Mycobacterium tuberculosis, quelle que soit la localisation (pulmonaire ou extra pulmonaire)
- Infection à Mycobactérie identifiée ou non, disséminée ou extra pulmonaire
- Pneumopathie bactérienne récurrente
- Leuco-encéphalite multifocale progressive
- Septicémie cachectique due au VIH
- Toxoplasmose cérébrale
- Septicémie à salmonella non typhique récurrente
- Syndrome cachectique dû au VIH
- Pneumonie à pneumocystose carinii



Classification du VIH CDC 2008

	<i>CD4</i>	<i>Clinique</i>
<i>Stade 1</i>	CD4 $\geq$ 500 cel/mm ³ (CD4 $>$ 29%)	Non requis
<i>Stade 2</i>	CD4 : 200-499 cel/mm ³ (CD4 : 14-28%)	Non requis
<i>Stade 3</i>	CD4 $<$ 200 cel/mm ³ (CD4 $<$ 14%)	Manifestations cliniques définissant le sida



QCM

Les critères suivants permettent de classer un patient infecté par le VIH au stade A :

- A. Primo-infection symptomatique
- B. Absence de symptômes
- C. Pneumopathie récidivante
- D. Tuberculose pulmonaire
- E. Lymphadénopathie généralisée persistante



QCM

Les critères suivants permettent de classer un patient infecté par le VIH au stade A :

- A. Primo-infection symptomatique
- B. Absence de symptômes
- C. Pneumopathie récidivante
- D. Tuberculose pulmonaire
- E. Lymphadénopathie généralisée persistante

A – B – E



QCM

Les candidoses qui définissent le stade SIDA sont :

- A. Candidose oropharyngée**
- B. Candidose pharyngée persistante**
- C. Candidose bronchique**
- D. Candidose de l'œsophage**
- E. Candidose intestinale**



QCM

Les candidoses qui définissent le stade SIDA sont :

- A. Candidose oropharyngée**
- B. Candidose pharyngée persistante**
- C. Candidose bronchique**
- D. Candidose de l'œsophage**
- E. Candidose intestinale**

C – D



QCM

Les infections virales qui définissent le SIDA sont :

- A. Zona récurrent**
- B. Mononucléose infectieuse**
- C. Rétinite à Cytomégalovirus (CMV)**
- D. Colite à CMV**
- E. Herpes génital récurrent**



QCM

Les infections virales qui définissent le SIDA sont :

- A. Zona récurrent**
- B. Mononucléose infectieuse**
- C. Rétinite à Cytomégalovirus (CMV)**
- D. Colite à CMV**
- E. Herpes génital récurrent**

C – D



QCM

Le diagnostic de SIDA est porté chez un sujet séropositif pour le VIH qui présente :

- A. une pneumocystose**
- B. une tuberculose cavitaire pulmonaire**
- C. un muguet buccal**
- D. un zona multi métamérique**
- E. une langue chevelue**



QCM

Le diagnostic de SIDA est porté chez un sujet séropositif pour le VIH qui présente :

- A. une pneumocystose**
- B. une tuberculose cavitaire pulmonaire**
- C. un muguet buccal**
- D. un zona multi métamérique**
- E. une langue chevelue**

A – B



QCM

Le diagnostic de SIDA est porté chez un sujet séropositif pour le VIH qui présente :

- A. Une pneumocystose**
- B. Une tuberculose pulmonaire**
- C. Une candidose vaginale persistante**
- D. Un zona multimétamérique**
- E. Une leucoplasie chevelue de la langue**



QCM

Le diagnostic de SIDA est porté chez un sujet séropositif pour le VIH qui présente :

- A. Une pneumocystose**
- B. Une tuberculose pulmonaire**
- C. Une candidose vaginale persistante**
- D. Un zona multimétamérique**
- E. Une leucoplasie chevelue de la langue**

A – B



QROC

Citer 3 pathologies appartenant au groupe C :



QROC

Citer 3 pathologies appartenant au groupe C :

- **Cancer invasif du col**
- **Candidose pulmonaire ou œsophagienne**
- **Cryptococcose extra-pulmonaire**
- **Histoplasmosse**
- **Infection à MAC**
- **Toxoplasmosse cérébrale**



Stade 3 : SIDA

- Toxoplasmose
- Pneumocystose
- Cryptococcose
- Infection à CMV, HSV
- Encéphalopathie VIH
- LEMP
- Septicémie à salmonelle
- Tuberculose, histoplasmosse
- Infection à mycobactérie atypique
- Pneumopathie bactérienne récurrente
- Cryptosporidiose, isosporose, microsporidiose, coccidiomycose
- Candidose oesophagienne
- Sarcome de kaposi (HHV8)
- Lymphome de Burkitt (EBV)
- Lymphome immunoblastique
- Lymphome cérébral primitif
- Cancer invasif du col
- Syndrome cachectique dû au VIH



QROC

Quels sont les cancers les plus fréquemment associés au VIH ?



QROC

Quels sont les cancers les plus fréquemment associés au VIH ?

- **Sarcome de Kaposi**
- **Lymphome cérébral primitif**
- **Cancer invasif du col**
- **Lymphome malin non hodgkinien**
- **Cancer liés au virus (EBV, HPV)**
- **Cancer anorectal**



QROC

- **Citer 3 infections opportunistes dont le risque de survenue est important si le taux de CD4 est $< 100/\text{mm}^3$ chez les patients infectés par le VIH:**



QROC

- **Citer 3 infections opportunistes dont le risque de survenue est important si le taux de CD4 est $< 100/\text{mm}^3$ chez les patients infectés par le VIH:**
 - **Cryptococcose**
 - **Infection à CMV**
 - **Cryptosporidiose**
 - **Mycobactérie atypique**



Traitement antirétroviral

Objectifs

- 1 Restauration de l'immunité cellulaire.
- 2 CVP indétectable à 6 mois
- 3 $\uparrow$ $CD4 > 500$.
- 4 $\downarrow$ risque de transmission sexuelle du VIH.
- 5 $\downarrow$ morbi-mortalité
- 6 Améliorer la qualité de vie.

➔ Cas clinique : Suite ...

■ Examen clinique : Candidose





Faut-il commencer le traitement anti-rétrovirale chez notre patient ?

A. Oui

B. Non



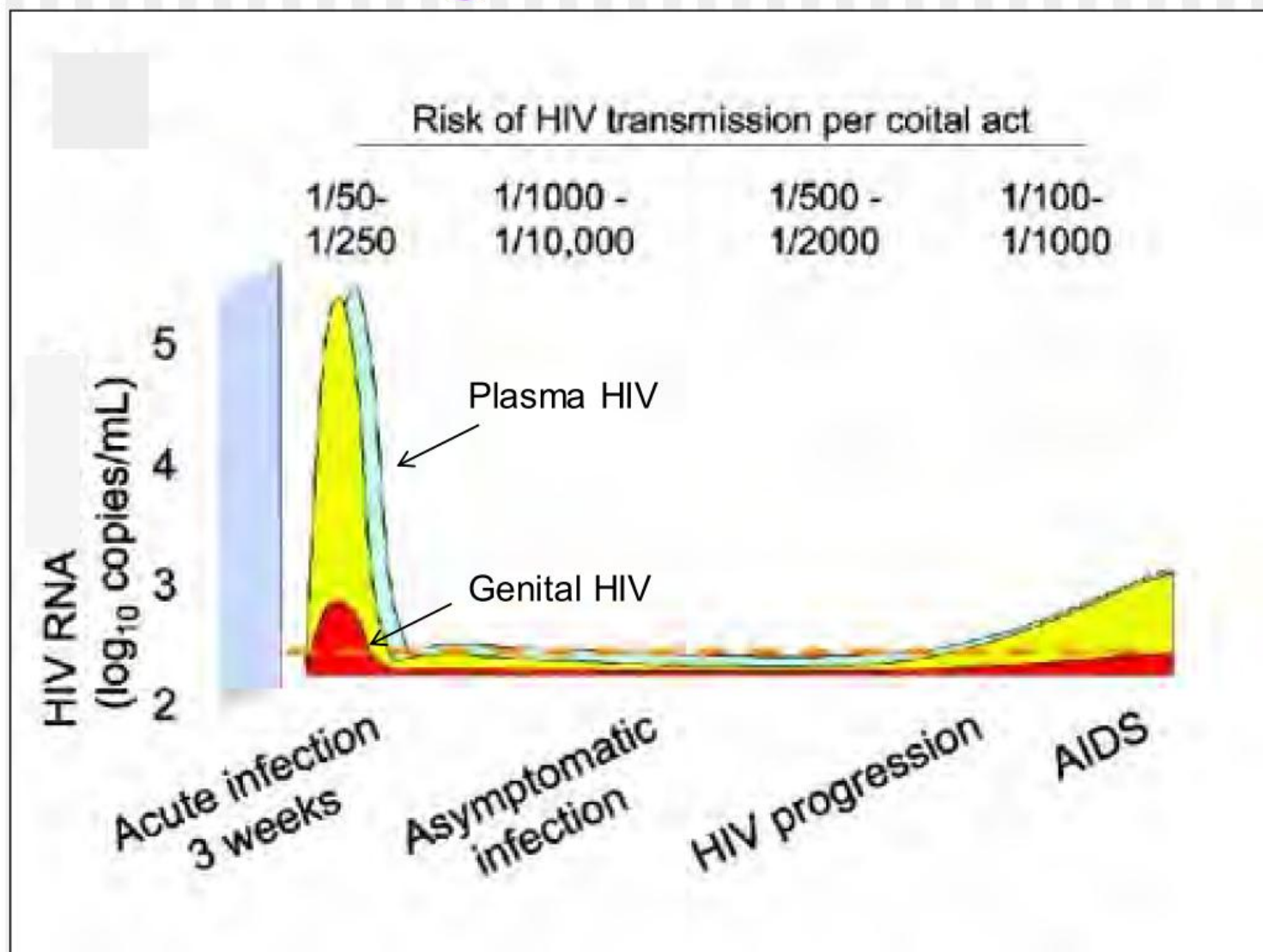
Faut-il commencer le traitement anti-rétrovirale chez notre patient ?

A. Oui

B. Non

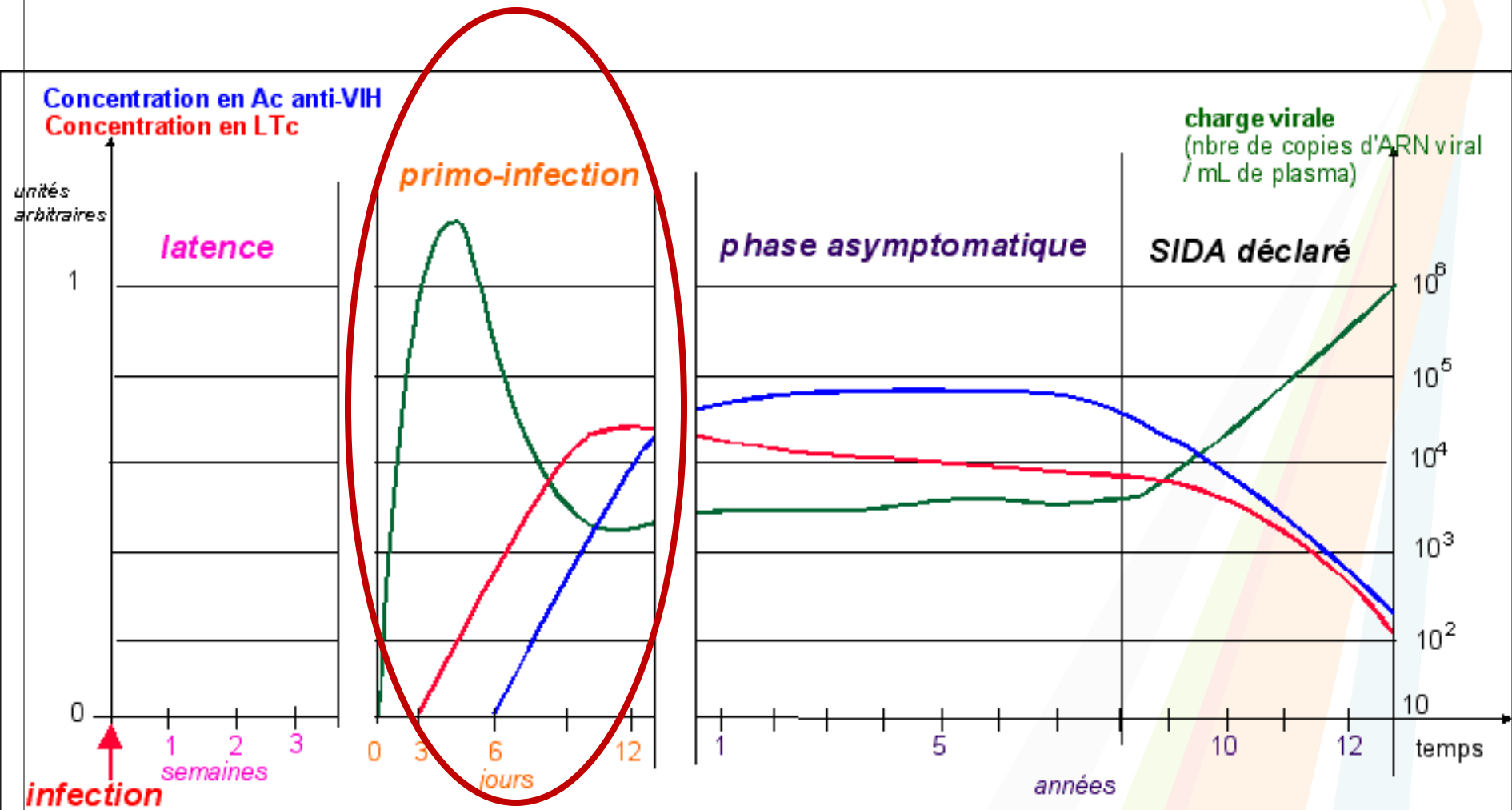
Réponse : A

Risk of HIV Transmission by Stage of Infection



Cohen & Pilcher. *J Infect Dis* 2005; 191(9): 1391-3.

Pourquoi faire le dépistage de la primo-infection ?





QROC

Citer 5 indications du traitement ARV :



QROC

Citer 5 indications du traitement ARV :

Dépistage → traitement

- **CD4 < 500/mm³**
- **Présence d'infection opportuniste**
- **Co-infection VHB ou VHC**
- **Néphropathie liée au VIH**
- **ARN VIH >100 000 copies/mL**
- **Femme enceinte**
- **> 50 ans**
- **Nouveau-né de mère positive non traitée**
- **Facteurs de risques cardiovasculaire**



QROC

Citer les principes généraux du traitement d'une infection VIH :



QROC

Citer les principes généraux du traitement d'une infection VIH :

- **Trithérapie antirétrovirale : 2 NRTI + IP / NNRTI / II (observance)**
- **Prophylaxie des infections opportunistes si $CD4 < 200/mm^3$**
- **Traitement préventif : rapports sexuels protégés, mesures générales**
- **Surveillance**



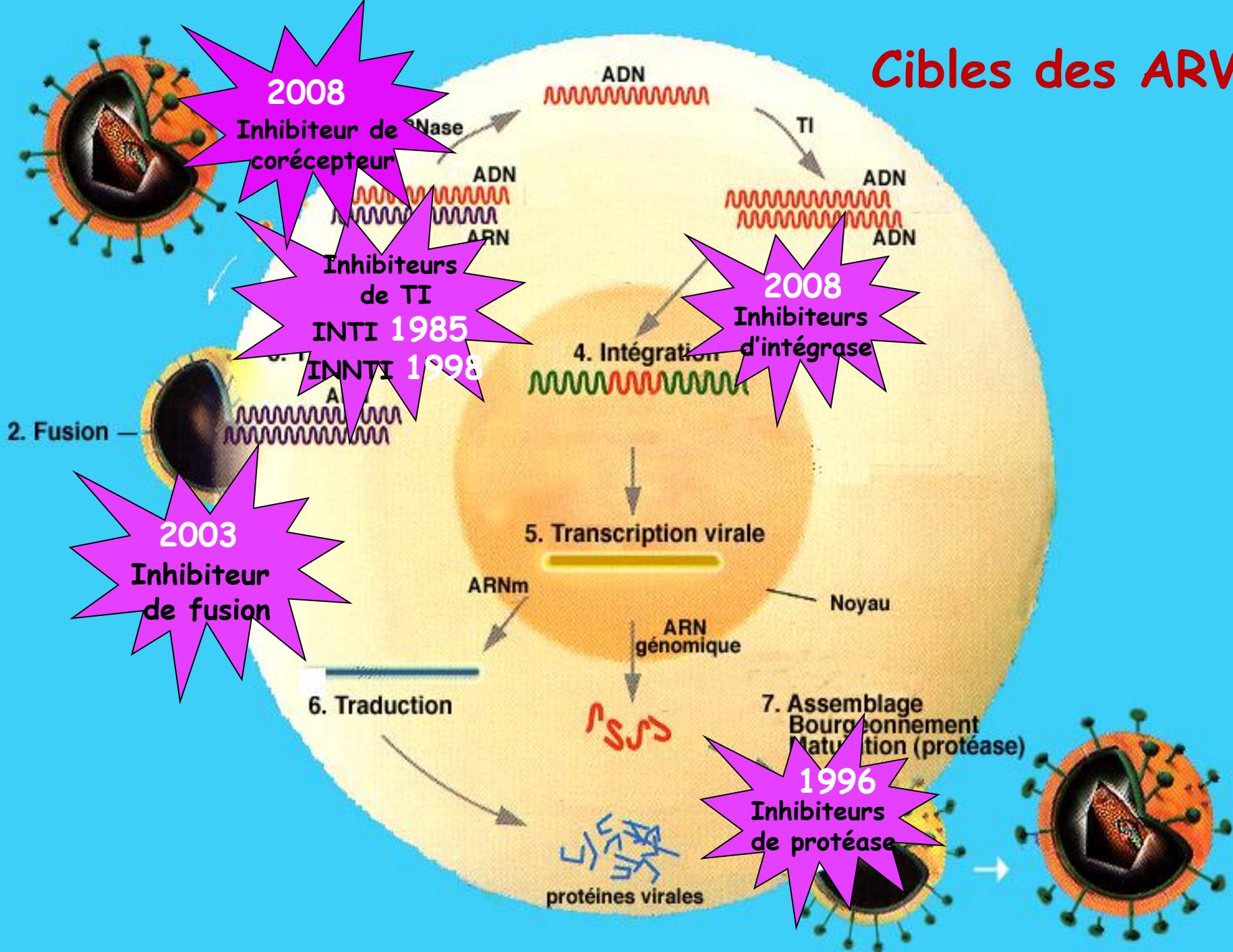
Quel traitement
initial ?



ARV : 5 «sites», 6 «classes»

- Corécepteurs de l'entrée du virus
 - Inhibiteur du corécepteur CCR5 (1)
- Fusion virus-cellule
 - Inhibiteur de fusion (injectable, 1)
- Transcription inverse (INTI et INNTI)
 - Inhibiteurs nucléosidiques (6)
 - Inhibiteur nucléotidique (1)
 - Inhibiteurs non-nucléosidiques (3)
- Protéase (IP)
 - Antiprotéases (8)
- Intégrase
 - Inhibiteurs de l'intégrase (1)

Cibles des ARV





Le traitement de 1^{ère} intention anti-rétrovirale comporte ?

- A. 2 INTI + 1 INNTI
- B. 2 INTI + 1 IP
- C. 1 INTI + 2 INNTI
- D. 1 INTI + 2 IP
- E. 3 INTI



Le traitement de 1^{ère} intention anti-rétrovirale comporte ?

- A. 2 INTI + 1 INNTI
- B. 2 INTI + 1 IP
- C. 1 INTI + 2 INNTI
- D. 2 INTI + 1 II
- E. 3 INTI

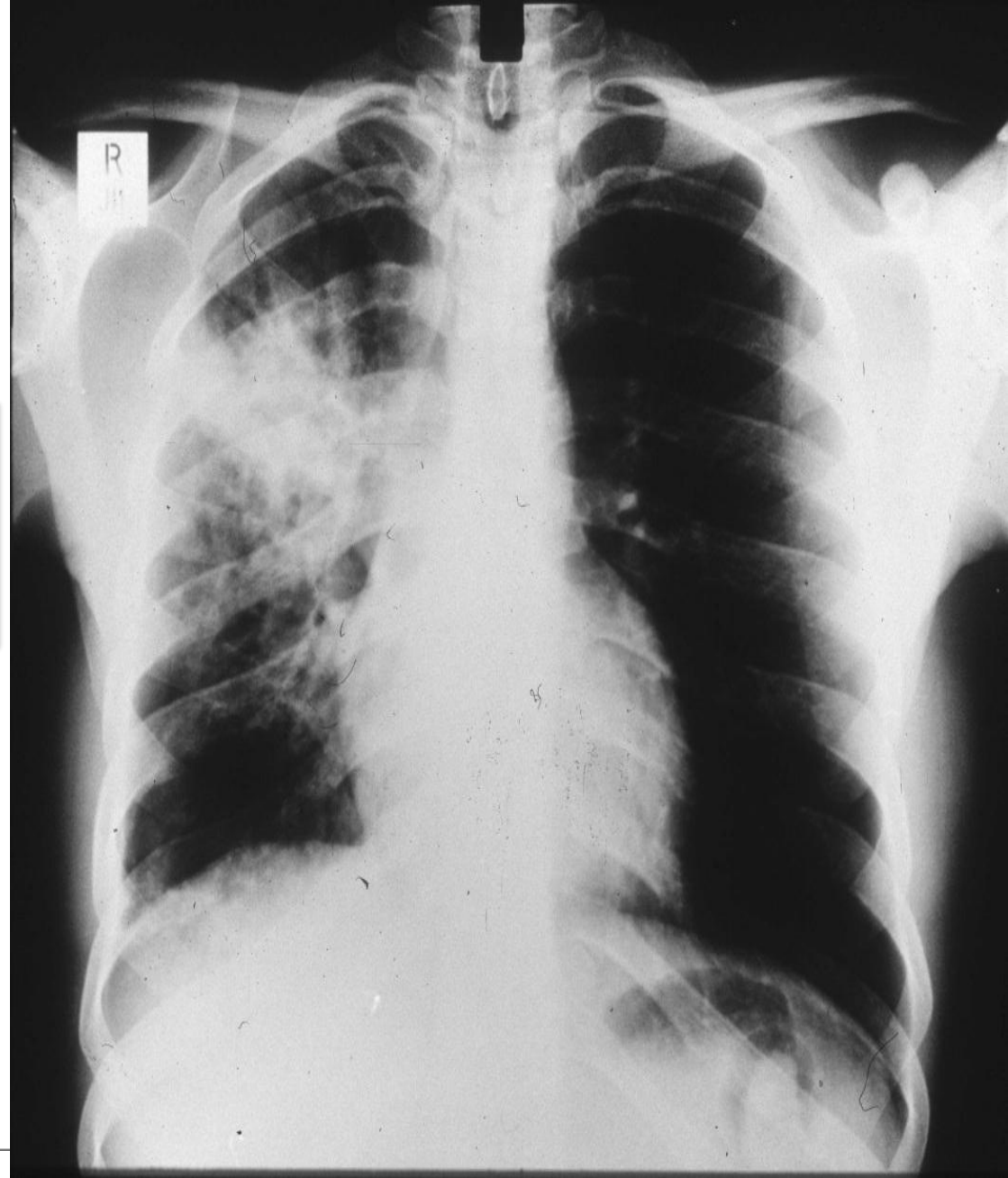
Réponse : A-B-D

➔ Cas clinique : Suite ...

- On a prescrit pour notre patient :
Truvada® (Ténofovir/emtricitabine) 1 cp/j
+
Stocrine® (Efavirenz) 1 cp/j
- Après 10 mois :
 - Fièvre + AEG + Toux (2 mois)
 - Rx thorx



Rx thorax de face





Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Pneumocystose pulmonaire**
- B. Pneumopathie à pneumocoque**
- C. Légionellose**
- D. Tuberculose pulmonaire**
- E. Pneumopathie à coronavirus**



Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Pneumocystose pulmonaire**
- B. Pneumopathie à pneumocoque**
- C. Légionellose**
- D. Tuberculose pulmonaire**
- E. Pneumopathie à coronavirus**

Réponse : D



- **Si ce Monsieur consulte pour une fièvre à 38,5°C associée à une toux sèche et à un essoufflement depuis quelques jours.**



Quel diagnostic suspectez-vous de première intention ?

- **Chez un patient HIV+,**
- **CD4<200**
- **atteinte pulmonaire en l'absence de prophylaxie primaire de la pneumocystose :**

→ Une pneumocystose pulmonaire.



Cas clinique QCM

Un patient infecté par le VIH présente une dyspnée fébrile évoluant depuis quelques jours. L'examen note une maigreur, une cyanose et des râles crépitants diffus.

Q1/ Quels sont les diagnostics à évoquer ?



Cas clinique QCM

Un patient infecté par le VIH présente une dyspnée fébrile évoluant depuis quelques jours. L'examen note une maigreur, une cyanose et des râles crépitants diffus.

Q1/ Quels sont les diagnostics à évoquer ?

- **Tuberculose**
- **Pneumocystose**
- **Pneumopathie à CMV**
- **Sarcome de Kaposi pulmonaire**
- **Mycobactériose atypique**



Quel examen sera le plus contributif pour affirmer le diagnostic que vous suspectez ?



Quel examen sera le plus contributif pour affirmer le diagnostic que vous suspectez ?

- **Fibroscopie bronchique avec lavage broncho alvéolaire à la recherche de pneumocystis *par PCR***



Quels autres examens demandez-vous ?



Quels autres examens demandez-vous ?

- **GDS: évaluer la gravité de la pneumocystose et l'hypoxie**
- **Radiographie de thorax**
- **Recherche de BK dans les crachats**
- **IDR à la tuberculine**
- **LDH**



Quel traitement prescrivez-vous initialement ?

- **Hospitalisation, Repos, oxygénothérapie**
- **Traitement spécifique :**
 - **IV : Cotrimoxazole – Bactrim® : 4 ampoule x3/j**
 - **Per os: Cotrimoxazole – Bactrim Fort® 800 mg : 2 cp
x 3/j pdt 21 jours**
 - **Acide folinique 25 mg/j**
 - **Corticoïdes ?**
 - **Si PaO₂ < 70 mmHg: Prednisone**
 - **S1 : 60 mg, S2 : 40 mg, S3 : 20 mg**



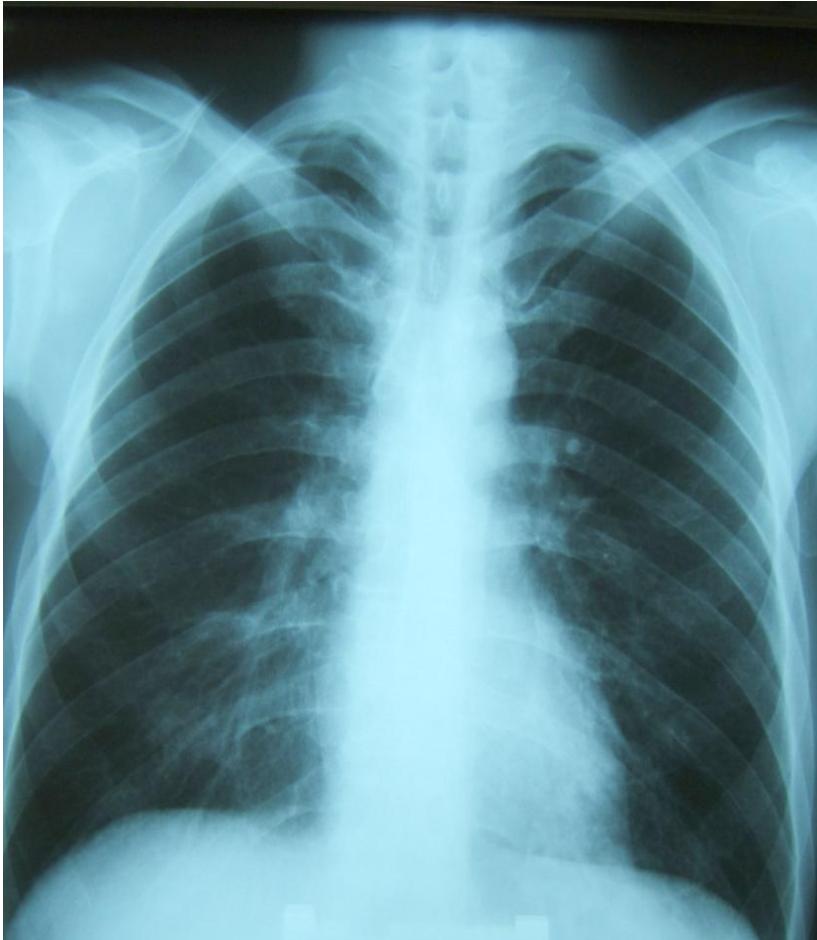
Après la guérison de l'épisode actuel, quel traitement prescrivez-vous?

Bactrim : 1 cp/j

il s'agit d'une prophylaxie secondaire de la pneumocystose



Pneumocystose pulmonaire





Pneumocystose pulmonaire

Clinique :

Début peu symptomatique

→ toux sèche

→ dyspnée d'effort

→ fébricule

Aggravation très progressive



Pneumocystose : Ex Complémentaires ?

Radiographie thoracique

Syndrome alvéolo-interstitiel diffus, bilatéral

Gaz du sang

hypoxémie +/- grave ($< 70\text{mmHg}$)

- **Fibroskopie bronchique : ++**

Lavage broncho-alvéolaire

(Expectoration induite pour certains)



Pneumocystose : Traitement ?

Début avant les résultats : Urgence +++

Triméthoprine/Sulfaméthoxazole

15/75 mg/kg/j en 3 prises

Bactrim® IV 12 amp/j ou 6 cp/j de Bactrim fort®

+ Léderfoline®

pendant 21 jours

+/- corticoïdes si PaO_2 très basse

➡ Cas clinique : Suite ...

- En effet il n'a pas reçu son TTT ARV
- RBK crachat : (+)
- On a commencé un traitement anti-TBC:
 - HRZE (4cp/j) + Vit B6 → 2 mois
 - Puis HR (4cp/j) → 4 mois
- A 30 jours du traitement on a repris le TTT ARV

➔ Cas clinique : Suite ...

- Après 7 mois de l'arrêt du TTT anti-TBC
- Il se présente:
 - Hémiplégie gauche
 - BAV
 - ➔ TDM cérébrale en urgence



QROC

Devant un syndrome déficitaire chez un patient infecté par le VIH, **quels sont les diagnostics à évoquer ?**



QROC

Devant un syndrome déficitaire chez un patient infecté par le VIH, **quels sont les diagnostics à évoquer ?**

- Lymphome cérébral
- **Toxoplasmose cérébrale**
- Tuberculose cérébrale
- Cryptococcose cérébrale
- AVC ischémique



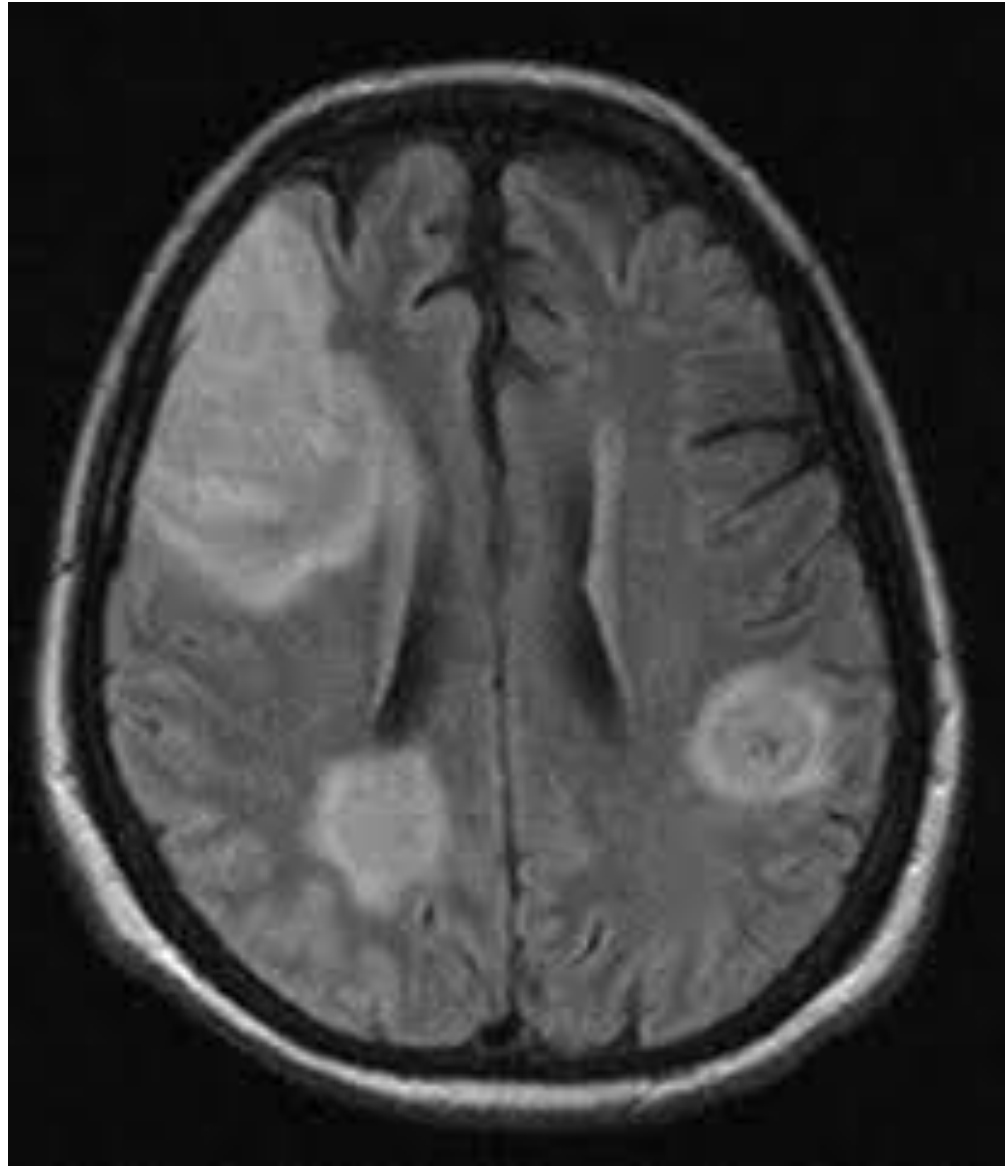
TDM cérébrale

Cocarde





IRM cérébrale





Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Tuberculose cérébrale**
- B. Toxoplasmose cérébrale**
- C. Lymphome cérébral**
- D. Cryptococcome cérébral**
- E. LEMP**



Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Tuberculose cérébrale**
- B. Toxoplasmose cérébrale**
- C. Lymphome cérébral**
- D. Cryptococcome cérébral**
- E. LEMP**

Réponse : B



Les arguments épidémio-cliniques en faveur de la toxoplasmose cérébrale sont :

- A. L'ancienneté de l'infection par le VIH**
- B. Taux de CD4 à 40**
- C. L'absence de prophylaxie primaire anti-toxoplasmose**
- D. Signes neurologiques de localisation**
- E. L'absence d'antécédent d'infections opportunistes**



Les arguments épidémio-cliniques en faveur de la toxoplasmose cérébrale sont :

- A. L'ancienneté de l'infection par le VIH**
- B. Taux de CD4 à 40**
- C. L'absence de prophylaxie primaire anti-toxoplasmose**
- D. Signes neurologiques de localisation**
- E. L'absence d'antécédent d'infections opportunistes**

B – C – D



**Quel est l'examen para-clinique de confirmation de la
Toxoplasmose cérébrale :**

- A. Une sérologie toxoplasmique**
- B. Recherche de toxoplasmes par PCR dans le LCR**
- C. Scanner cérébral**
- D. Biopsie cérébrale stéréotaxique avec anapath**
- E. Cytochimie du liquide céphalorachidien**



**Quel est l'examen para-clinique de confirmation de la
Toxoplasmose cérébrale :**

- A. Une sérologie toxoplasmique**
- B. Recherche de toxoplasmes par PCR dans le LCR**
- C. Scanner cérébral**
- D. Biopsie cérébrale stéréotaxique avec anapath**
- E. Cytochimie du liquide céphalorachidien**

D



Parmi ces anti-infectieux, quels sont ceux qui sont indiqués dans la prévention primaire de la toxoplasmose cérébrale :

- A. Sulfadiazine (Adiazine®)**
- B. Pyriméthamine (Malocide®)**
- C. Spiramycine (Rovamycine®)**
- D. Clindamycine (Dalacine®)**
- E. Cotrimoxazole (Bactrim®)**



Parmi ces anti-infectieux, quels sont ceux qui sont indiqués dans la prévention primaire de la toxoplasmose cérébrale :

- A. Sulfadiazine (Adiazine®)**
- B. Pyriméthamine (Malocide®)**
- C. Spiramycine (Rovamycine®)**
- D. Clindamycine (Dalacine®)**
- E. Cotrimoxazole (Bactrim®)**

E



Quelle sera la durée de traitement Anti-toxoplasmique ?

Triméthoprine/sulfaméthoxazole (cotrimoxazole,
15/75 mg/kg/j en 3 à 4 prises) sous
forme intraveineuse ou orale.

→ ≥ 6 semaines



Quelle sera la durée de traitement Anti-toxoplasmique ?

Prophylaxie secondaire :

Cotrimoxazole 400 : 2 cp/j



Les arguments qui permettent de retenir ce diagnostic sont :

- A. Présence d'abcès multiples en cocarde au scanner cérébral**
- B. Sérologie toxoplasmique positive**
- C. Présence d'œdème papillaire au fond d'œil**
- D. Réponse favorable au traitement spécifique**
- E. Albuminorrachie supérieure à 1 g/L**



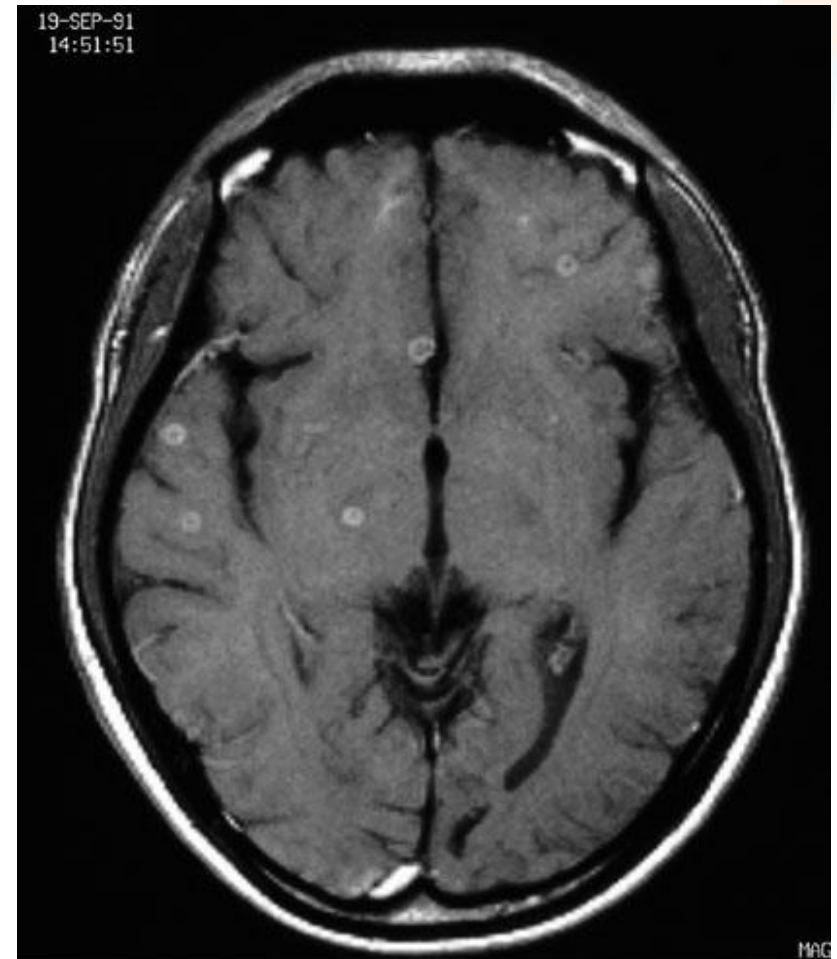
Les arguments qui permettent de retenir ce diagnostic sont :

- A. Présence d'abcès multiples en cocarde au scanner cérébral**
- B. Sérologie toxoplasmique positive**
- C. Présence d'œdème papillaire au fond d'œil**
- D. Réponse favorable au traitement spécifique**
- E. Albuminorrachie supérieure à 1 g/L**

A - B - D



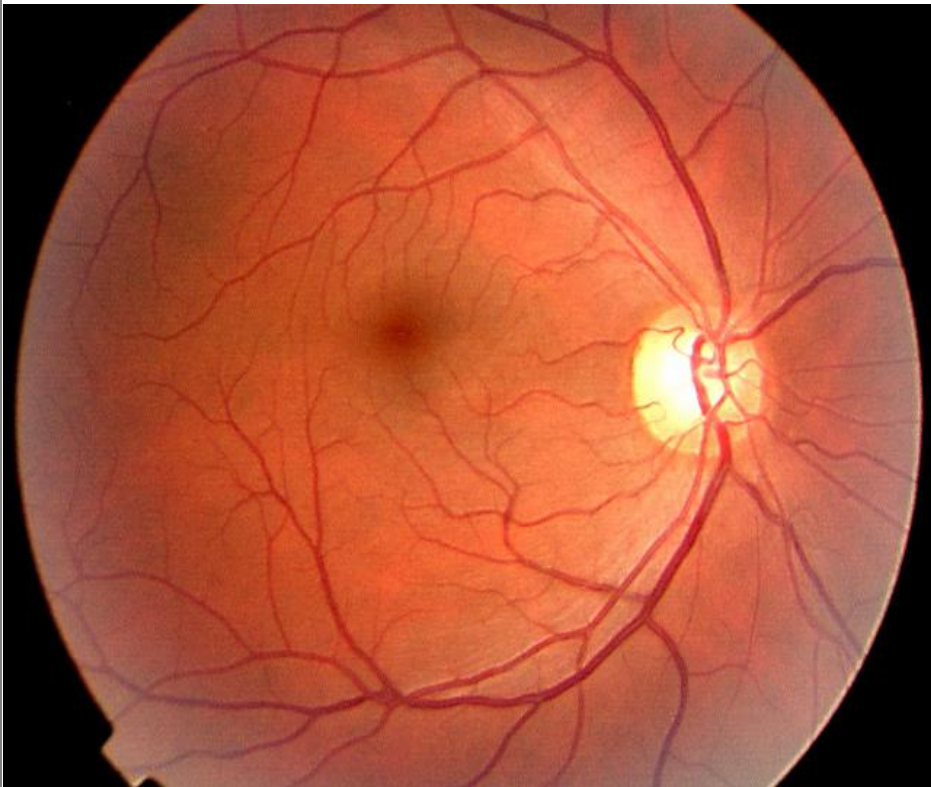
Tuberculome





Un Fond d'œil fait ...

Fond d'œil normal



Rétinite à CMV





Quel est le traitement curatif de
la rétinite à CMV ?

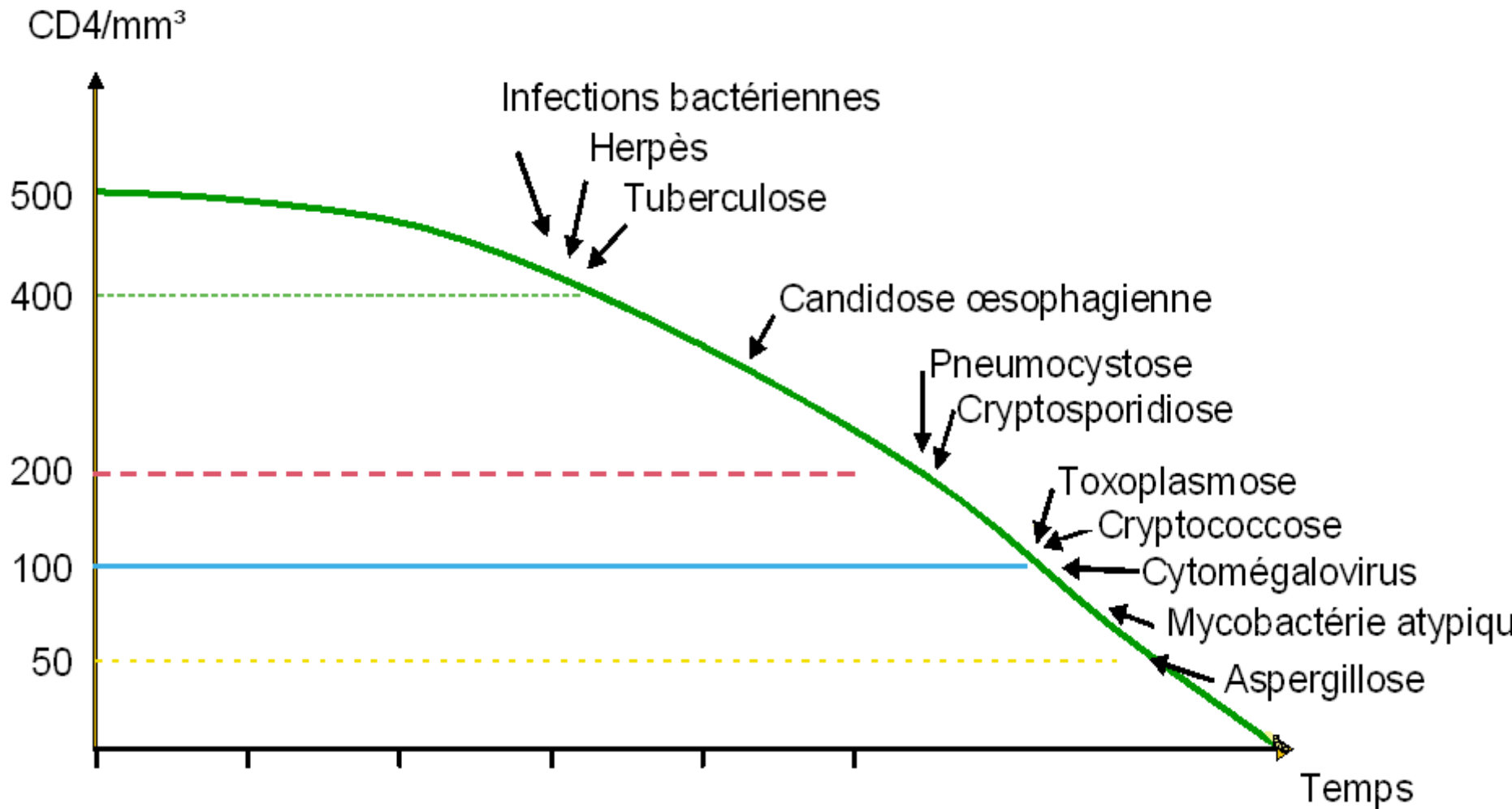
Ganciclovir IV (5 mg/kg x 2/j)
21 j



Quel est la durée du traitement de la rétinite à CMV ?

- Pendant 3 semaines
 - un traitement d'entretien par valganciclovir 900 mg/j en une prise
- ➔ Arrêt si: $CD4 > 100/mm^3$ pendant 3 mois

➔ VIH: Infections opportunistes en fonction du taux de CD4





QCM

Au cours de l'infection à VIH :

- A. Le traitement ARV est indiqué si le taux de CD4 est $< 500/\text{mm}^3$
- B. La pneumocystose pulmonaire fait partie des infections opportunistes les plus fréquentes
- C. La cryptococcose neuro-méningée est l'infection opportuniste la plus fréquente du SNC
- D. Une antibioprophylaxie par cotrimoxazole est indiquée si le taux de CD4 est $< 200/\text{mm}^3$
- E. La charge virale VIH est un marqueur d'évolutivité de la maladie



QCM

Au cours de l'infection à VIH :

- A. Le traitement ARV est indiqué si le taux de CD4 est $< 500/\text{mm}^3$
- B. La pneumocystose pulmonaire fait partie des infections opportunistes les plus fréquentes
- C. La cryptococcose neuro-méningée est l'infection opportuniste la plus fréquente du SNC
- D. Une antibioprophylaxie par cotrimoxazole est indiquée si le taux de CD4 est $< 200/\text{mm}^3$
- E. La charge virale VIH est un marqueur d'évolutivité de la maladie

A – B – D

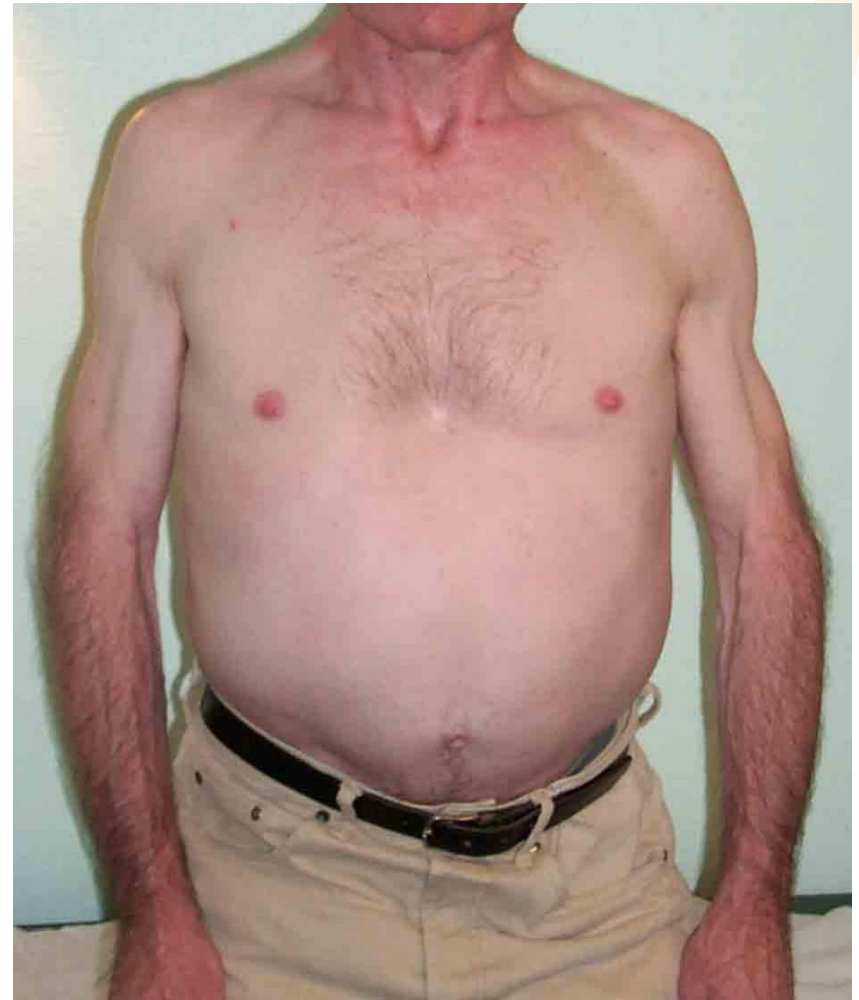
**Cette fois il a décidé de
prendre son traitement
antirétroviral**



➔ **Cas clinique : Suite ...**
20 ans, bonne observance du TTT



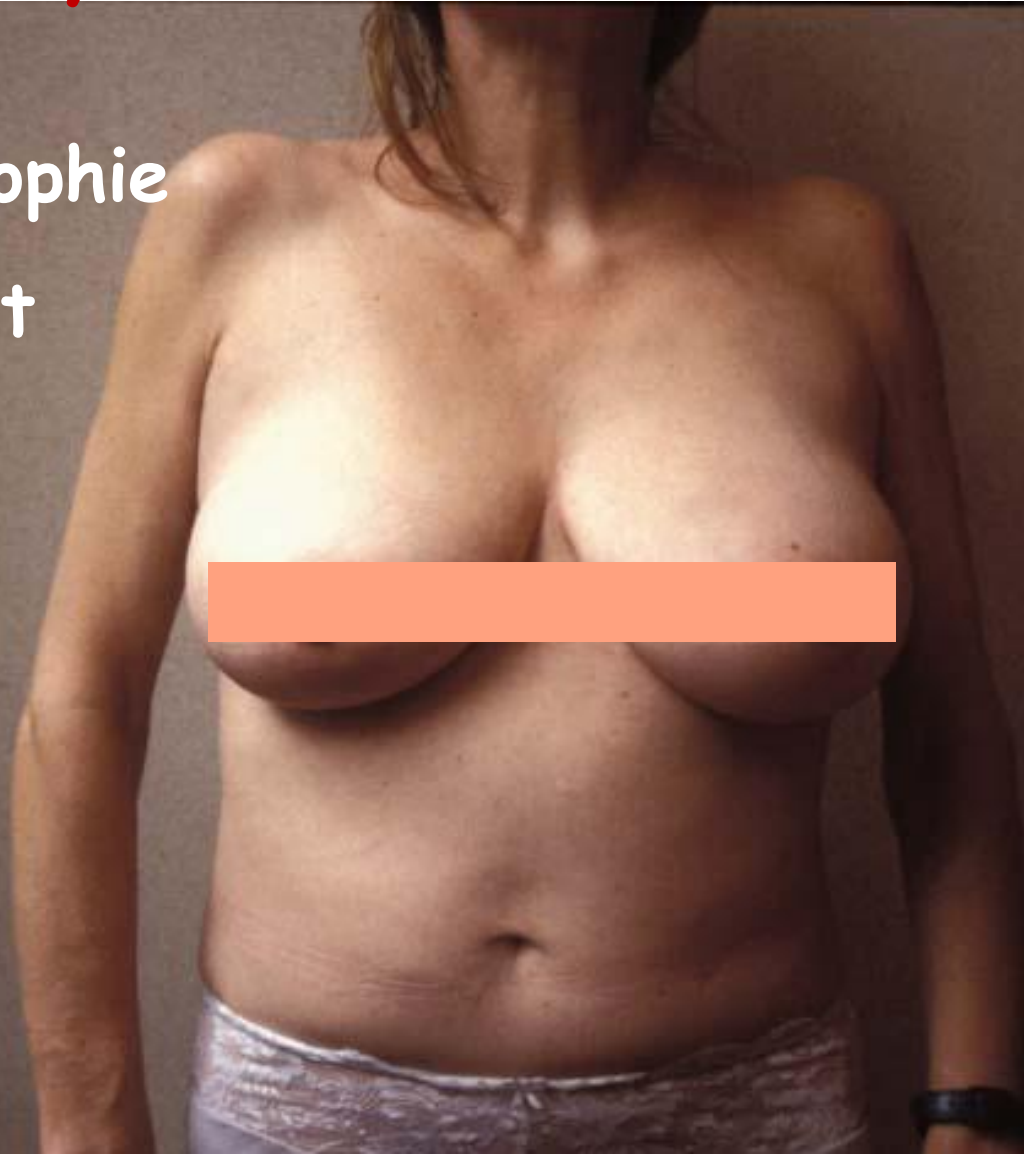
Lipoatrophie du visage



Augmentation du tour de taille

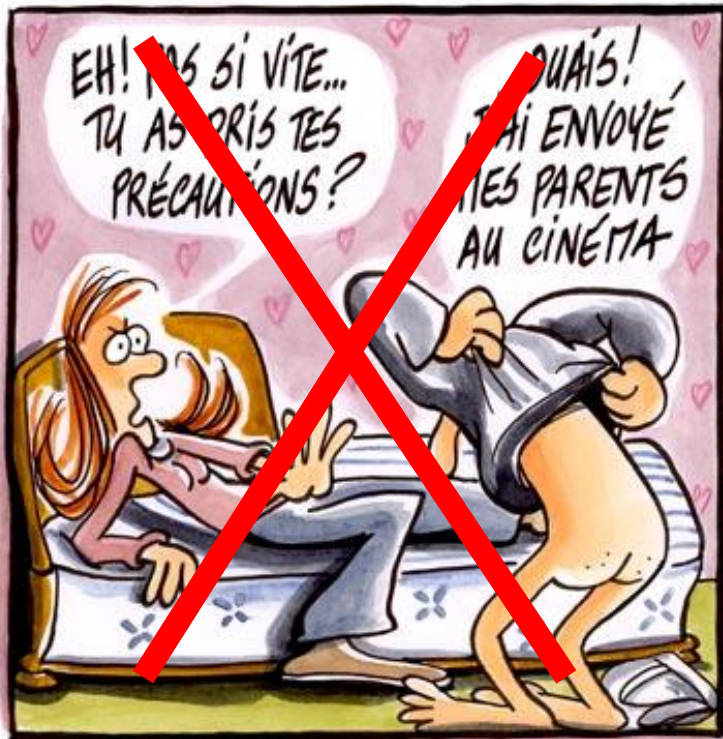
➔ Cas clinique : Partenaire 20 ans, bonne observance du TTT

Lipohypertrophie
mammaire et
abdominale



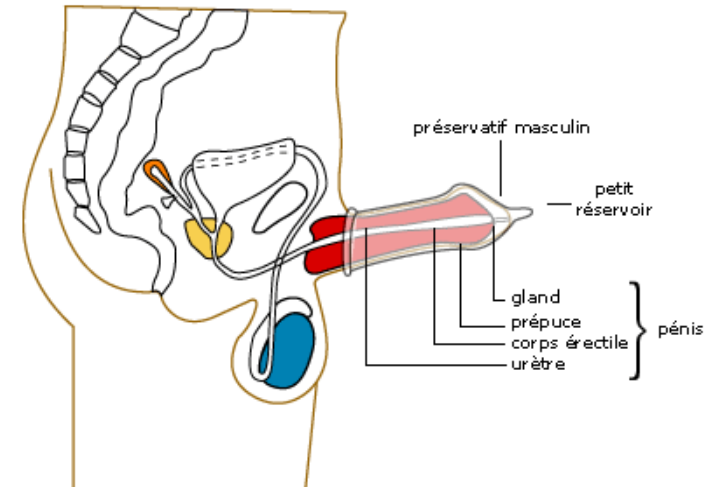
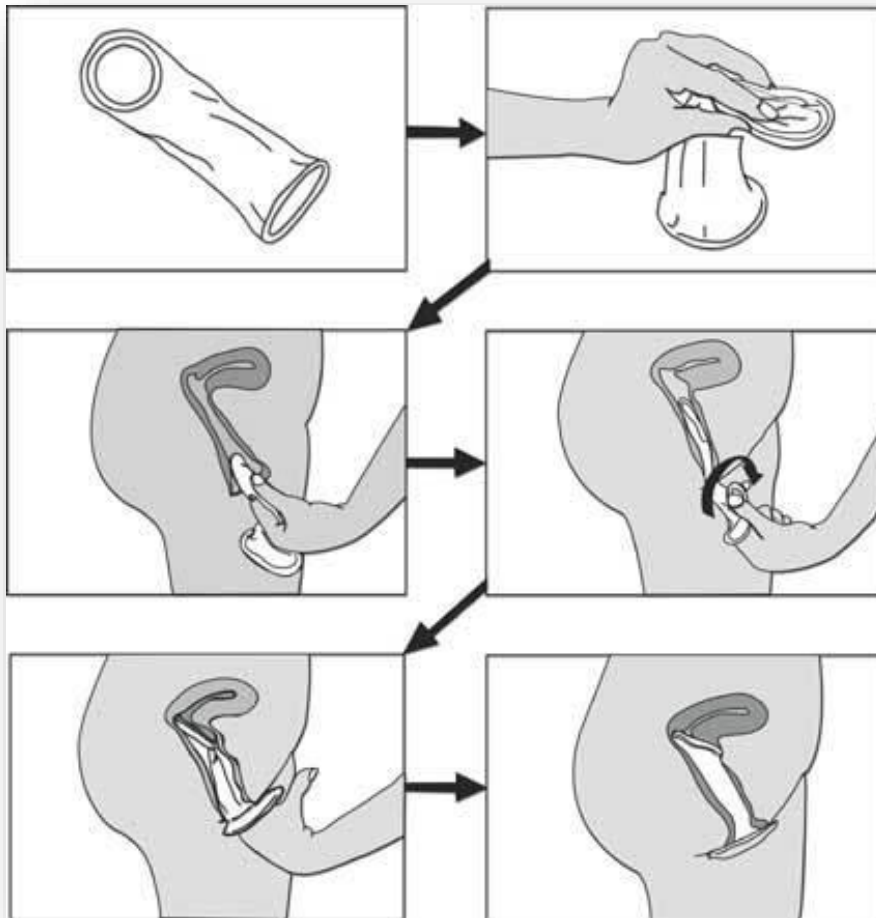


**LE SIDA NE SE GUÉRIT PAS ENCORE.
PENSEZ À VOUS PROTÉGER.**





Usage du préservatif !!!





QROC

Citer 3 mesures de prévention de l'infection VIH :



QROC

Citer 3 mesures de prévention de l'infection VIH :

- **Préservatif**
- **Dépistage** si comportement à risque
- **Traitement ARV** après exposition à un risque de transmission par le VIH



QROC

Citer 3 mesures de prévention de la transmission materno-fœtale de l'infection VIH :



QROC

Citer 3 mesures de prévention de la transmission materno-fœtale de l'infection VIH :

- **Dépistage systématique proposé devant toute grossesse**
- **ARV si femme séropositive à partir de 26 SA**
- **Césarienne**
- **Pas d'allaitement au sein**



Indications du traitement post exposition en cas d'AES

Risque et nature de l'exposition	Statut VIH de la personne source		
	Positif		Inconnu
	CV détectable	CV < 50 copies/ml	
Important : – piqûre profonde, aiguille creuse intra-vasculaire (artérielle et veineuse)	TPE recommandé	TPE non recommandé*	TPE recommandé
Intermédiaire : – coupure avec bistouri – piqûre avec aiguille IM ou SC – piqûre avec aiguille pleine – exposition cutanéomuqueuse avec temps de contact > 15 mn	TPE recommandé	TPE non recommandé*	TPE non recommandé*
Faible : – piqûres avec seringues abandonnées – crachats, morsures ou griffures autres cas	TPE non recommandé*		



Suivi biologique en cas d'AES

J1-J7	- Sérologie VIH - Sérologie VHC - Anti-HBs (si vacciné et titre Ac inconnu) ou Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs (si non-vacciné) - ALAT - Créatinine, test de grossesse (si indication de TPE)
S2	- ALAT, créatinine (si TPE et comorbidité ou recherche d'effets indésirables)
S6	- Sérologie VIH (si TPE ou en l'absence de TPE si sujet source de statut VIH inconnu ou VIH+ avec charge virale détectable) - ALAT et ARN VHC (si ARN VHC+ chez sujet source)
S12	- Sérologie VIH(selon GERES 2019, arrêté du 26 Mai 2019 : demandée à S12 sauf en cas de TPE) - Sérologie VHC - Ag HBs, Anti-HBc et Anti-HBs (si absence d'immunité de la personne exposée et sujet source Ag HBs+ ou de statut inconnu)



Le concept de prévention combinée associe, au niveau de la population

- **Le dépistage comme outil de prévention**
- **Le traitement ARV comme outil de prévention**
- **Les méthodes comportementales**
- **Le contrôle des facteurs de risque de transmission**



Individuellement, quel est le moyen de prévention du VIH le plus efficace ?

- a. La circoncision
- b. Le préservatif
- c. Le traitement antirétroviral du partenaire séropositif (TasP)
- d. Le traitement antirétroviral du partenaire séronégatif (PrEP)
- e. Un programme de conseil d'abstinence

Individuellement, quel est le moyen de prévention du VIH le plus efficace ?

- a. La circoncision
- b. Le préservatif
- c. Le traitement antirétroviral du partenaire séropositif (TasP)
- d. Le traitement antirétroviral du partenaire séronégatif (PrEP)
- e. Un programme de conseil d'abstinence

C

Dans l'ordre !

a. Le traitement antirétroviral du partenaire séropositif
(TasP)

96 %

b. Le préservatif

90 %

c. Le traitement antirétroviral du partenaire séronégatif
(PrEP)

86 %

d. La circoncision

60 %

e. Un programme de conseil d'abstinence

0 %



Conclusion

IST

- 1 Fréquente
- 2 Grave → morbi-mortalité ++
- 3 VIH : en croissance
- 4 Prévention → réduction
- 5 Abstinence
- 6 Fidélité réciproque
- 7 Condom



Merci pour votre attention

- Makram Koubaa : Tél : 21 880 402



- E-mail : makram.koubaa@gmail.com

- **facebook**

Makram Koubaa



- **@Makram_Koubaa**

